

Buku Ajar

PEMERIKSAAN FISIK DALAM KEPERAWATAN



Hadi Kusuma Atmaja • Erien Luthfia
Ni Putu Sumartini • Lale Wisnu Andrayani • Mira Utami Ningsih

Buku Ajar:

Pemeriksaan Fisik dalam Keperawatan

Hadi Kusuma Atmaja

Erien Luthfia

Ni Putu Sumartini

Lale Wisnu Andrayani

Mira Utami Ningsih



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Ajar:

Pemeriksaan Fisik dalam Keperawatan

Penulis:

Hadi Kusuma Atmaja
Erien Luthfia
Ni Putu Sumartini
Lale Wisnu Andrayani
Mira Utami Ningsih

ISBN : 978-634-7556-52-3

Desain Sampul : Ivan Zumarano

Penata Letak : Achmad Faisal

Cetakan Pertama : Februari, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI



Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal & @optimal.penerbit

Tiktok : @bimbelukomoptimal

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Buku Pemeriksaan Fisik dalam Keperawatan** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar serta keterampilan pemeriksaan fisik secara sistematis dan komprehensif dalam praktik keperawatan.

Pemeriksaan fisik merupakan bagian penting dalam proses pengkajian keperawatan sebagai identifikasi kondisi kesehatan klien. Oleh karena itu, pemeriksaan fisik yang tepat sangat diperlukan agar tenaga kesehatan mampu mengenali masalah kesehatan secara dini dan mendukung pengambilan keputusan klinis yang akurat.

Buku ini membahas tentang pemeriksaan fisik pada berbagai sistem tubuh, mulai dari sistem integumen, kepala dan leher, thoraks, abdomen, muskuloskeletal, neurologis, hingga pemeriksaan genetalia dan anus. Materi disusun secara ringkas, sistematis, dan dilengkapi dengan latihan soal di setiap bab untuk menunjang pemahaman mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa Buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan masukan yang membangun sangat membantu dalam penyempurnaan di masa mendatang. Semoga Buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna dalam proses pembelajaran keperawatan.

Penulis

Ringkasan

Buku Pemeriksaan Fisik dalam Keperawatan ini membahas konsep dan teknik pemeriksaan fisik sebagai bagian penting dalam pengkajian keperawatan. Materi disusun untuk memberikan pemahaman dasar serta panduan praktis dalam melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis dan tepat.

1. Bab I membahas pemeriksaan integumen dan kuku yang meliputi anatomi fisiologi dari kulit dan kuku, serta teknik pemeriksaan kulit, rambut, dan kuku.
2. Bab II menguraikan pemeriksaan kepala dan leher, termasuk mata, telinga, hidung, mulut, dan leher. Sehingga pemeriksaan kepala meliputi beberapa sistem tubuh, dengan demikian pemeriksaan fisik pada kepala akan lebih sistematis dan membantu keputusan klinis secara tepat
3. Bab III membahas pemeriksaan thoraks yang mencakup sistem pernapasan dan kardiovaskular, seperti pemeriksaan fisik pada paru-paru, jantung, payudara, dan axilla dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.
4. Bab IV menjelaskan pemeriksaan abdomen meliputi berbagai organ dalam sehingga pemeriksaan akan dibagi dengan kuadran agar dapat mempermudah pemeriksaan pada organ-organ yang ada pada kuadran tersebut.
5. Bab V membahas pemeriksaan sistem muskuloskeletal yang mana mengacu pada otot, tulang, sendi, ligamen, tendon, dan tulang rawan pada tubuh.
6. Bab VI menguraikan pemeriksaan neurologis seperti nerus cranialis dan tingkat kesadaran pada manusia.
7. Bab VII membahas pemeriksaan genetalia dan anus dengan memperhatikan aspek etika dan privasi pasien.

Secara keseluruhan, Buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa atau pembaca meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemeriksaan fisik secara profesional.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Ringkasan.....	iv
Daftar Isi.....	v

BAB 1 Pemeriksaan Integumen dan Kuku 1

A. Anatomi Fisiologi Sistem Integumen.....	1
B. Pemeriksaan Fisik Sistem Integumen.....	4
C. Latihan Soal.....	7
D. Standar Operasional Prosedur.....	2

BAB 2 Pemeriksaan Kepala dan Leher 9

A. Pemeriksaan pada Kepala.....	9
B. Pemeriksaan pada Mata.....	10
C. Pemeriksaan pada Telinga.....	11
D. Pemeriksaan pada Hidung.....	14
E. Pemeriksaan Mulut.....	14
F. Pemeriksaan Leher.....	15
G. Latihan Soal.....	18
H. Standar Operasional Prosedur.....	9

BAB 3 Pemeriksaan Thorax..... 20

A. Pengertian Pemeriksaan Thorax.....	20
B. Pemeriksaan Fisik Paru-Paru.....	20
C. Pemeriksaan Fisik Jantung.....	27
D. Pemeriksaan Fisik Payudara.....	33
E. Pemeriksaan Axilla.....	37
F. Latihan Soal.....	38
G. Standar Operasional Prosedur.....	21

BAB 4 Pemeriksaan Abdomen 41

A. Anatomi Abdomen.....	41
B. Pemeriksaan Fisik.....	43
C. Palpasi.....	44
D. Perkusi.....	45
E. Definisi Auskultasi Dan Cara Pemeriksaan Auskultasi.....	46
F. Cara Pemeriksaan Inspeksi Abdomen.....	47
G. Latihan Soal.....	48
H. Standar Operasional Prosedur.....	41

BAB 5 Pemeriksaan Muskuloskeletal	52
A. Pengertian Sistem Muskuloskeletal.....	52
B. Jenis dan Fungsi Sistem Muskuloskeletal.....	52
C. Pemeriksaan Muskuloskeletal	56
D. Latihan Soal	58
E. Standar Operasional Prosedur	51
 BAB 6 Pemeriksaan Neurologis	 61
A. Pengertian Pemeriksaan Neurologis	61
B. Prosedur Pemeriksaan Fisik Nervus Cranialis	63
C. Pemeriksaan Neurologis Refleks Fisiologis	65
D. Pemeriksaan Neurologis Tingkat Kesadaran.....	66
E. Pemeriksaan Neurologis Nervus Kranialis	67
F. Latihan Soal	68
G. Standar Operasional Prosedur	59
 BAB 7 Pemeriksaan Genetalia dan Anus.....	 72
A. Anatomi Genetalia dan Anus	72
B. Prosedur Pemeriksaan Fisik Genetalian dan Anus.....	76
C. Latihan Soal	79
D. Standar Operasional Prosedur	68
 Daftar Pustaka.....	 82
Kunci Jawaban.....	84

BAB 1

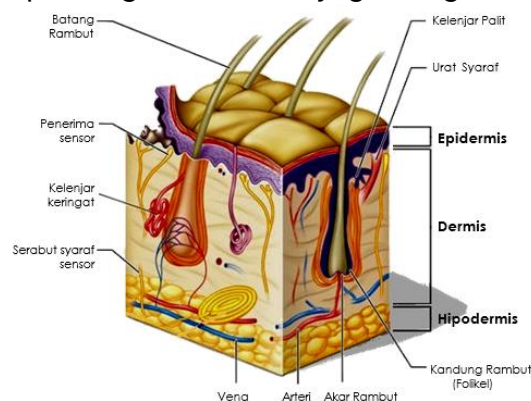
Pemeriksaan Integumen dan Kuku

A. Anatomi Fisiologi Sistem Integumen

Integumen terdiri dari kulit, rambut, dan kuku. Istilah "integumen" berasal dari kata Latin "integumentum," yang berarti penutup atau pelindung tubuh.

1. Anatomi Fisiologi Kulit

Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia yang menyumbang sekitar 7% dari total berat badan. Organ ini memiliki fungsi esensial dalam mencegah kehilangan cairan secara berlebihan serta melindungi tubuh dari masuknya berbagai faktor lingkungan, seperti mikroorganisme, zat kimia, dan paparan radiasi ultraviolet. Selain itu, kulit berperan dalam menahan pengaruh mekanik, termasuk gesekan dan getaran, serta berfungsi sebagai alat sensorik untuk mendeteksi perubahan kondisi fisik di lingkungan sekitar. Dengan kemampuan tersebut, individu dapat menghindari rangsangan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Secara keseluruhan, kulit berfungsi sebagai penghalang antara organ internal dan lingkungan eksternal, serta berkontribusi penting dalam menjaga fungsi vital tubuh.



Gambar 1.1 Skema Bagian – Bagian Kulit

Kulit tersusun atas 3 lapisan:

a. Epidermis

Epidermis berasal dari ektoderm, terdiri dari beberapa lapis (multilayer). Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia

b. Dermis

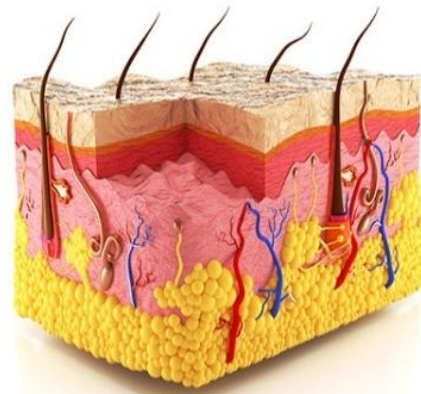
Dermis atau kulit jangat merupakan lapisan kulit yang terletak tepat di bawah epidermis. Lapisan ini terutama tersusun atas serat kolagen dan membentuk bagian terbesar dari struktur kulit, sehingga berperan penting dalam memberikan kekuatan serta kerangka penunjang bagi kulit. Ketebalan dermis bervariasi sesuai dengan lokasi tubuh dan dapat mencapai sekitar 4 mm pada area punggung. Sifat dermis yang kuat sekaligus elastis memungkinkan lapisan ini melindungi jaringan yang berada di bagian lebih dalam.

c. Subkutan atau Hipodermis

Lapisan subkutan atau hipodermis adalah lapisan kulit terdalam yang terdiri dari jaringan ikat dan lemak. Lapisan ini terletak di bawah dermis dan berfungsi untuk menghubungkan kulit ke jaringan fibrosa di bawahnya.

2. Anatomi Fisiologi Rambut

Rambut merupakan struktur menyerupai serabut yang tersusun dari keratin bersifat elastis, berasal dari lapisan epidermis, dan menyebar hampir di seluruh permukaan tubuh. Namun, rambut tidak ditemukan pada telapak tangan, telapak kaki, permukaan dorsal falang distal, serta area sekitar anus dan urogenital.



Gambar 1.2 Struktur Anatomi Kulit Manusia

Secara anatomi, rambut terdiri atas dua bagian utama:

a. Batang Rambut

Batang rambut merupakan bagian rambut yang terdapat di luar kulit. Bila dibuat potongan rambut akan terlihat dari luar ke dalam.

b. Akar Rambut

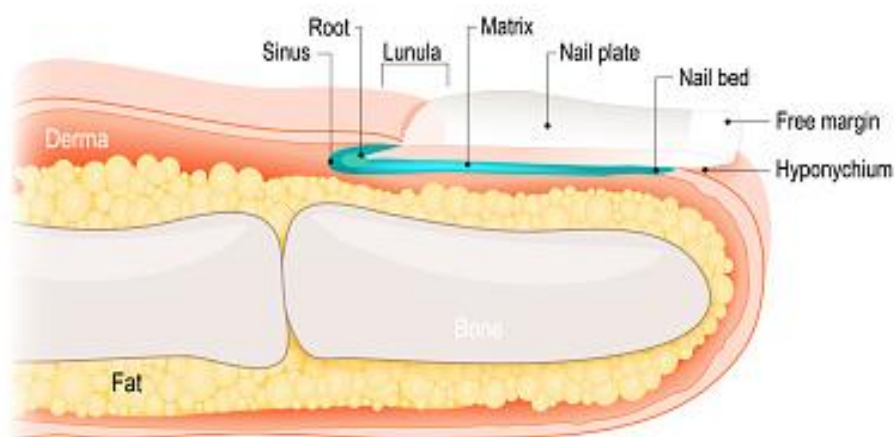
Akar rambut merupakan bagian rambut yang tertanam miring ke dalam kulit, terselubung oleh kantung rambut (folikel rambut). Akar rambut ini tertanam sangat dalam, dapat mencapai lapisan hipodermis.

3. Anatomi Fisiologis Kuku

Kuku adalah struktur berbentuk lempeng yang berfungsi melindungi permukaan dorsal falang pada jari tangan dan jari kaki. Struktur kuku memiliki keterkaitan erat dengan lapisan dermis dan epidermis. Proses pertumbuhan kuku berlangsung mengikuti garis lengkung datar dan pada bagian proksimal tumbuh dengan arah sedikit miring terhadap permukaan kulit.

Bagian kuku terdiri dari :

- Matriks kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru
- Dinding kuku (*nail wall*) merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas.
- Dasar kuku (*nail bed*) merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku.
- Alur kuku (*nail groove*) merupakan celah antar dinding dan dasar kuku.
- Akar kuku (*nail root*) merupakan bagian proksimal kuku.
- Lempeng kuku (*nail plate*) merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku.
- Lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih didekat akar kuku berbentuk bulan sabit, sering tertutup oleh kulit.
- Eponikium (*kutikula*) merupakan dinding kuku bagian proksima, kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku.
- Hiponikium merupakan dasar kuku, kulit ari dibawah kuku yang bebas (*free edge*) menebal.



Gambar 1.3 Anatomi Kuku Manusia

B. Pemeriksaan Fisik Sistem Integumen

1. Kulit

Kemampuan perawat dalam melakukan pengkajian fisik, harus disertai dengan pemahaman yang baik mengenai anatomi dan fungsi kulit, memungkinkan setiap perubahan atau penyimpangan dari kondisi normal dapat terdeteksi, dilaporkan, dan didokumentasikan secara tepat.



Gambar 1.4 Gradasi Warna Kulit Manusia

Pemeriksaan kulit merupakan tindakan noninvasif. Lesi pada kulit dapat terbatas pada lapisan epidermis, namun dalam beberapa kondisi dapat melibatkan jaringan kulit yang lebih dalam.

a. Warna

Warna kulit normal menunjukkan variasi antarindividu, mulai dari rona gading hingga cokelat tua. Area tubuh yang sering terpapar lingkungan luar, terutama di wilayah beriklim panas dengan paparan sinar matahari tinggi, umumnya memiliki pigmentasi lebih gelap dibandingkan bagian tubuh lainnya. Vasodilatasi yang terjadi akibat kondisi seperti demam, paparan sinar matahari berlebihan, atau proses inflamasi dapat menyebabkan kulit tampak berwarna merah muda hingga kemerahan. Pucat menggambarkan kondisi menurunnya atau hilangnya tonus serta vaskularisasi kulit yang normal, dan paling mudah diamati pada konjungtiva. Sianosis ditandai dengan perubahan warna kebiruan pada kulit yang mencerminkan adanya hipoksia seluler, dan biasanya terlihat jelas pada ekstremitas, dasar kuku, bibir, serta membran mukosa. Sementara itu, ikterus ditandai dengan perubahan warna kekuningan pada kulit yang berkaitan dengan peningkatan kadar bilirubin dalam serum, dan sering tampak pada sklera serta membran mukosa.

b. Tekstur kulit

Tekstur kulit normalnya lembut dan kencang. Paparan matahari, proses penuaan, dan perokok berat akan membuat kulit sedikit lembut. Normalnya kulit adalah clastic dan dapat cepat kembali apabila dilakukan pencubitan yang sering disebut dengan turgor kulit baik.

- c. Suhu
Suhu kulit normalnya hangat, walaupun pada beberapa kondisi pada bagian perifer seperti tangan dan telapak kaki akan terasa dingin akibat suatu kondisi vasokonstriksi.
- d. Kelembapan
Secara normal kulit akan terasa kering apabila disentuh. Pada beberapa kondisi seperti adanya peningkatan aktivitas dan pada peningkatan kecemasan, kelembapan akan meningkat.
- e. Bau busuk
Kulit normalnya tidak berbau yang mengengikan. Bau yang tajam secara normal dapat ditemukan pada peningkatan produksi keringat terutama pada area aksila dan lipit paha.
 - 1) Inspeksi
 - a) Lihat warna kulit klien bahwa sinar matahari. Normalnya kulit berwarna cerah merah muda hingga kecokelatan ataupun hitam. Kulit yang tidak terkena sinar matahari akan berwarna lebih terang, dan tampak pucat pada orang yang tidak pernah/jarang terpapar sinar matahari.
 - b) Lihat adanya lesi pada kulit (primer ataupun sekunder).
 - c) Lihat apakah kulit klien tampak berminyak.
 - 2) Palpasi
 - a) Rasakan suhu pada permukaan tubuh, normalnya tubuh akan terasa hangat.
 - b) Cubit sedikit pada bagian dada, atau lengan bagian dalam. Turgor kulit akan kembali dalam waktu 2 detik (nilai normal).
 - c) Untuk mengetahui adanya pitting edema, tekan perlahan pada daerah pretibialis, dorsum pedis, atau sacrum. Jika ditemukan pitting edema, pada area yang ditekan akan tampak bekas jari pemeriksa dan akan kembali dengan lambat (> 2 detik).

2. Rambut

- a. Inspeksi
 - 1) Perhatikan penyebaran rambut di seluruh tubuh, penyebaran rambut akan tampak lebih banyak pada pria dibandingkan wanita. Lihat kebersihannya, catat adanya tinea kapitis, tinea korporis, kutu, dan lain-lain. Lihat warnanya, warna rambut berbeda-beda tergantung suku bangsanya.



Gambar 1.5 Rambut

- 2) Rasakan apakah rambut berminyak. Tarik sedikit rambut, catat jika ada kerontokan rambut atau alopesia (rontok berlebihan).
- b. Palpasi
Rasakan apakah rambut berminyak. Tarik sedikit rambut, catat jika ada kerontokan rambut atau alopesia (rontok berlebihan).

3. Kuku

Kondisi kuku dapat mencerminkan keadaan kesehatan secara umum, status nutrisi, jenis pekerjaan, serta tingkat perawatan diri seseorang. Bahkan, aspek psikologis juga dapat teridentifikasi, misalnya melalui adanya tanda-tanda kebiasaan menggigit kuku. Sebelum melakukan pengkajian kuku, perawat perlu mengumpulkan riwayat singkat yang relevan. Bagian kuku yang paling mudah diamati adalah lempeng kuku, yaitu lapisan transparan yang tersusun dari sel epitel dan menutupi bantalan kuku. Warna pada lapisan di bawah kuku dipengaruhi oleh vaskularisasi bantalan kuku.



Gambar 1.6
Pemeriksaan Kuku

Area putih berbentuk setengah bulan di bagian dasar bantalan kuku disebut lunula, yang merupakan tempat awal pembentukan lempeng kuku.

- 1) Inspeksi
 - a) Perhatikan bentuk kuku dan warna dasar kuku. Normalnya dasar kuku berwarna merah muda cerah karena mengandung banyak pembuluh darah.
 - b) Sudut normal antara kuku dengan pangkalnya adalah 160 derajat.
 - c) Perhatikan sekitar kuku, apakah ada lesi atau perlukaan.
- 2) Palpasi
 - a) Tekan ujung jari untuk memeriksa Capillary Refil Time (CRT) yaitu waktu pengisian balik kapiler. Normalnya akan kembali dalam waktu < 2 detik.

C. Latihan Soal

1. Sistem integumen terutama berfungsi sebagai...
 - A. Penghasil hormon
 - B. Alat gerak pasif
 - C. Pelindung tubuh dari lingkungan luar
 - D. Pengatur tekanan darah
2. Lapisan kulit yang berasal dari ektoderm adalah...
 - A. Dermis
 - B. Hipodermis
 - C. Epidermis
 - D. Subkutan
3. Fungsi utama dermis adalah...
 - A. Produksi melanin
 - B. Penyimpanan lemak
 - C. Memberikan kekuatan dan elastisitas kulit
 - D. Tempat pertumbuhan rambut
4. Lapisan kulit yang mengandung jaringan lemak disebut...
 - A. Epidermis
 - B. Dermis
 - C. Stratum korneum
 - D. Hipodermis
5. Rambut tidak ditemukan pada area berikut, kecuali...
 - A. Telapak tangan
 - B. Telapak kaki
 - C. Dorsal falang distal
 - D. Kulit kepala
6. Bagian rambut yang tertanam dalam kulit disebut...
 - A. Batang rambut
 - B. Folikel rambut
 - C. Akar rambut
 - D. Papila rambut
7. Lunula pada kuku merupakan...
 - A. Bagian ujung kuku
 - B. Dasar kuku
 - C. Area pembentukan kuku baru
 - D. Lipatan kulit kuku
8. Sudut normal antara kuku dan pangkal kuku adalah...
 - A. 90°
 - B. 120°
 - C. 140°
 - D. 160°
9. Nilai normal Capillary Refill Time (CRT) adalah...
 - A. < 1 detik
 - B. < 2 detik
 - C. < 3 detik
 - D. < 5 detik
10. Sianosis menunjukkan adanya...
 - A. Anemia
 - B. Hipoksia
 - C. Dehidrasi
 - D. Ikterus

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN FISIK INTEGUMEN DAN KUKU	
Pengertian	Melakukan pemeriksaan/pengkajian fisik secara lengkap
Tujuan	1. Menegakkan diagnosa 2. Mengenali kelainan pada klien 3. Sebagai data dasar
Persiapan Alat/Bahan	1. <i>Handscoon</i> non steril 2. <i>Penlight</i> 3. Metlin 4. Kasa 5. Bengkok 6. Buku catatan 7. Pena
Prosedur Tindakan	Tahap Persiapan: 1. Justifikasi identitas klien (nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis) 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan 3. Lakukan cuci tangan Komunikasi Terapeutik: 1. Perkenalkan diri 2. Jelaskan pada klien tujuan tindakan yang akan dilakukan 3. Jaga privasi klien dan atur lingkungan sekitar klien 4. Bantu klien untuk mengatur posisi senyaman mungkin Tahap Kerja Pemeriksaan Integumen dan Kuku 1. Amati kebersihan kulit pasien 2. Amati adanya kelainan pada kulit seperti: Eritema, papula, vesikula, pustule, ulkus, crusta, excoriasi, fissure, cicatrix, ptechie, hematoma, naevus pigmentosus, vititigo, tattoo, hemangioma, spider nevi, lichenifikasi, striae, anemi, sianosis, ikterus 3. Amati adanya Clubbing Fingers 4. Periksa kehangatan, kelembaban, dan tekstur kulit 5. Amati turgor kulit dengan mencubit perut atau punggung tangan, kondisi normal tampak bekas cubitan kembali kurang dari 3 detik 6. Amati pengisian darah kapiler/capillary Refill Time (CRT) dengan cara menekan ujung jari. Kondisi normal, jika warna kulit kembali kurang dari 3 detik. Tahap Terminasi 1. Lakukan cuci tangan 2. Lakukan evaluasi terhadap klien tentang kegiatan yang telah dilakukan Dokumentasi 1. Catat hasil tindakan yang telah dilakukan 2. Catat respon klien 3. Sampaikan hasil pemeriksaan pada klien 4. Lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya

BAB 2

Pemeriksaan Kepala dan Leher

A. Pemeriksaan pada Kepala



Gambar 2.1 Kepala Bagian Depan dan Belakang

Pemeriksaan kepala merupakan komponen penting dalam pemeriksaan fisik yang dilakukan untuk menilai kondisi serta mendeteksi adanya kelainan pada daerah kepala. Melalui pemeriksaan ini, tenaga kesehatan dapat mengenali kelainan struktural, tanda-tanda infeksi, maupun gangguan fungsi yang tidak selalu terlihat secara kasat mata tanpa penilaian yang menyeluruh.

Prosedur pemeriksaan kepala dilakukan melalui teknik inspeksi dan palpasi, yaitu:

1. Inspeksi

Inspeksi adalah pemeriksaan fisik dengan cara melihat bagian kepala secara kasat mata. Yang merupakan bagian dari pemeriksaan inspeksi pada kepala antara lain:

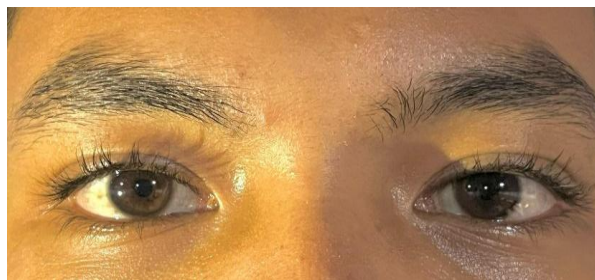
- a. Bentuk kepala (bulat/lonjong/benjol, besar/kecil, simetris/tidak)
- b. Posisi kepala terhadap tubuh (tegak lurus dan digaris tengah tubuh/tidak)
- c. Kulit kepala (ada luka/tidak, bersih/kotor, berbau/tidak, ada ketombe/tidak, ada kutu/tidak)
- d. Rambut pasien
 - 1) Penyebaran/pertumbuhan (rata/tidak)
 - 2) Keadaan rambut (rontok, pecah-pecah, kusam)
 - 3) Warna rambut (hitam, merah, beruban, atau menggunakan cat rambut)
 - 4) Bau rambut (berbau/tidak). Bila berbau apa penyebabnya.
- e. Wajah pasien
 - 1) Warna kulit wajah (pucat, kemerahan, kebiruan)
 - 2) Struktur wajah (simetris/tidak, ada luka/tidak, ada ruam dan pembengkakan/tidak, ada kesan sembab/ tidak, ada kelumpuhan otot-otot fasialis/tidak)

2. Palpasi

Palpasi kepala merupakan metode pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan meraba permukaan kepala pasien menggunakan tangan atau jari guna menilai kondisi kesehatannya. Yang merupakan bagian dari pemeriksaan palpasi pada kepala antara lain:

- a. Ubun-ubun (datar/cekung/cembung)
- b. Raba dan rasakan (ada/tidak): nyeri tekan, benjolan, tumor.
- c. Palpasi apakah ubun-ubun sudah menutup/belum.

B. Pemeriksaan pada Mata



Gambar 2.2 Mata

Pemeriksaan mata merupakan rangkaian tindakan evaluatif yang dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan mata serta fungsi penglihatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan atau gangguan pada mata, seperti gangguan refraksi, glaukoma, katarak, maupun penyakit mata lainnya. Berbagai metode dan tes digunakan dalam pemeriksaan mata guna menilai aspek penglihatan dan kesehatan mata secara komprehensif.

1. Inspeksi

- a. Kelengkapan dan kesimetrisan mata pasien (lengkap/tidak, simetris/tidak)
 - b. Alis mata dan bulu mata: pertumbuhan (lebat/rontok), posisi (simetris/tidak)
 - c. Kelopak mata (ada/tidak): lesi, edemda, peradangan, benjolan, tosis
 - d. Mearik kelopak mata bagian bawah dan mengamati konjungtiva (pucat/tidak), sklera (kuning atau tidak), dan adakah peradangan pada konjungtiva (warna kemerahan)
 - e. Pupil: bagaimana reflek pupil terhadap cahaya (baik/tidak), besar pupil kanan-kiri (sama/tidak), pupil mengecil/melebar.
 - f. Kornea dan iris: peradangan (ada/tidak), bagaimana Gerakan bola mata (normal/tidak)
 - g. Melakukan tes ketajaman penglihatan. Memeriksa visus Okuli Dekstra (OD) dan Okuli Sinistra (OS)
 - 1) Dengan grafik alfabet Snellen di jarak 5-6 meter. 5/5 atau 6/6 = normal
 - 2) 1/60 = (Normal) Mampu melihat dengan hitungan jari
 - 3) 1/300 = (normal) Mampu melihat dengan lambaian tangan
 - 4) 1/ ~ = (Normal) Mampu melihat gelap dan terang
 - 5) 0 = Tidak mampu melihat
 - h. Mengukur tekanan bola mata pasien dengan menggunakan tonometer. Nilai normal tekanan intra okuli 11-21 mmHg (rata-rata $16 \pm 2,5$ mmHg)
2. Palpasi
- Pemeriksaan palpasi meliputi pemeriksaan palpebra dan tekanan bola mata.

C. Pemeriksaan pada Telinga



Gambar 2.2 Telinga Kanan dan Kiri

1. Inspeksi dan Palpasi

- a. Telinga: Bentuk (simetris/tidak), ukuran (lebar/sedang/kecil), nyeri (ada/tidak)
- b. Lubang telinga, jika perlu menggunakan otoskop (periksa ada/tidak): serumen, benda asing, pendarahan
- c. Membran telinga (utuh/tidak)
- d. Jika perlu melakukan test keteajaman pendengaran. Memeriksa telinga kanan dan kiri
 - 1) Dengan bisikan pada jarak 4,5 – 6 m dalam ruangan kedap suara.
 - 2) Dengan arloji dengan jarak 30 cm
 - 3) Dengan garpu tala.

2. Pemeriksaan Rinne

Pemeriksaan Rinne merupakan pemeriksaan pendengaran menggunakan garpu tala untuk membandingkan hantaran melalui udara dan hantaran melalui tulang pada telinga yang diperiksa.

- a. Vibrasikan garpu tala, letakkan garpu tala pada mastoid kanan pasien, anjurkan pasien untuk memberi tahu sewaktu tidak merasakan getaran lagi.
- b. Angkat garpu tala dan pegang di depan telinga kanan pasien, anjurkan pasien untuk memberi tahu apakah masih mendengar suara getaran atau tidak. Normalnya suara getaran masih dapat didengar karena konduksi udara lebih baik daripada konduksi tulang.

Tes Rinne dinilai positif bila suara dari konduksi udara terdengar lebih keras dibandingkan konduksi tulang, dan Rinne negatif bila suara dari konduksi tulang lebih keras dari konduksi udara. Rinne positif akan didapatkan pada telinga normal atau tuli sensorineural. Rinne negatif akan didapatkan pada tuli konduktif.

3. Pemeriksaan Weber

Pemeriksaan Weber merupakan pemeriksaan pendengaran menggunakan garpu tala untuk membandingkan hantaran tulang telinga kiri dengan telinga kanan.

- a. Vibrasikan garpu tala, letakkan garpu tala di tengah-tengah puncak kepala pasien.
- b. Tanya pasien tentang telinga yang mendengar suara getaran lebih keras. Normalnya kedua telinga dapat mendengar secara seimbang sehingga getaran dirasakan ditengah-tengah kepala.

Pada tes Weber, tes diinterpretasikan sebagai tidak ada lateralisasi bila suara terdengar sama pada kedua telinga dan ada lateralisasi bila suara terdengar lebih keras pada salah satu telinga. Bila lateralisasi ke arah telinga sakit, maka telinga sakit menderita tuli konduktif. Sebaliknya, bila lateralisasi ke arah telinga kontralateral atau sehat, maka telinga sakit menderita tuli sensorineural.

4. Pemeriksaan Schwabach

Pemeriksaan Schwabach merupakan pemeriksaan pendengaran menggunakan garpu tala untuk membandingkan hantaran tulang orang diperiksa dengan pemeriksa yang pendengarannya normal. Syarat utama dilakukannya pemeriksaan ini adalah pemeriksa harus dipastikan terlebih dahulu memiliki pendengaran yang normal.

Dalam persiapan pasien, instruksikan pada pasien untuk memberikan isyarat ketika dia tidak merasakan getaran dari garpu tala.

- Vibrasikan Garpu tala, letakkan tangkai garpu tala pada Processus Mastoideus O. P. sampai pasien tidak merasakan getaran lagi.
- Setelah pasien tidak merasakan getaran, segera pindahkan garpu tala ke area Processus Mastoideus O. P. pemeriksa yang memiliki pendengaran normal.
- Bila pemeriksa masih dapat mendengar/ merasakan getaran, maka pemeriksaan Schwabach memendek.
- Bila pemeriksa tidak mendengar maka pemeriksaan diulang dengan cara sebaliknya. Ketika dilakukan pemeriksaan sebaliknya, bila pasien masih merasakan getaran, maka pemeriksaan Schwabach mengalami perpanjangan.

Pada tes Swabach, bila pemeriksa masih dapat mendengar suara, tes diinterpretasikan sebagai Swabach memendek (tuli sensorineural). Bila pemeriksa tidak dapat mendengar suara, pemeriksaan dilakukan dengan cara sebaliknya, dari telinga pemeriksa ke telinga pasien. Bila penderita masih dapat mendengar suara, tes diinterpretasikan sebagai Swabach memanjang (tuli konduktif)

Tabel 2.1 Interpretasi Tes Garpu Tala

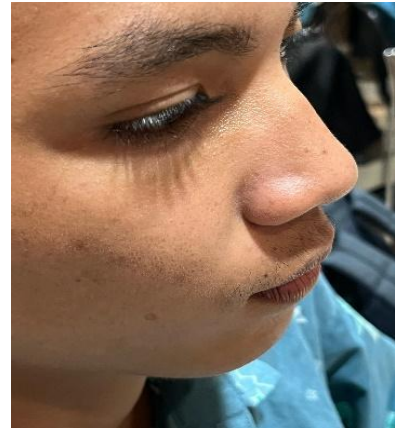
Rinne	Weber	Schwabach	Hasil
Positif	Tidak ada lateralisasi	Sama dengan Pemeriksa	Normal
Negatif	Lateralisasi ke telinga yang sakit	Memanjang	Tuli konduktif
Positif	Lateralisasi ke telinga yang sehat	Memendek	Tuli sensori neural

D. Pemeriksaan pada Hidung

Pemeriksaan hidung adalah prosedur medis untuk menilai kondisi rongga hidung, septum, turbinat, dan struktur lainnya guna mendeteksi kelainan seperti infeksi, alergi, polip, atau deviasi septum.

1. Inspeksi

- a. Bentuk tulang hidung dan posisi septum nasi (adakah pembengkokan/tidak)
- b. Lubang hidung, kalau perlu gunakan speculum hidung dan sumber cahaya yang kuat yang diarahkan dengan lampu kepala:
 - 1) Ada secret/tidak
 - 2) Ada sumbatan/tidak
 - 3) Ada inflamasi/tidak
 - 4) Selaput lender: kering/basah/lembab



Gambar 2.3 Hidung

2. Palpasi

Pemeriksaan palpasi hidung untuk menilai adanya fitur os nasalis dan nyeri tekan.

E. Pemeriksaan Mulut



Gambar 2.4 Mulut

Pemeriksaan mulut adalah tindakan medis yang dilakukan untuk menilai kesehatan rongga mulut, meliputi gigi, gusi, lidah, langit-langit, dinding mulut, serta jaringan lunak lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi berbagai kelainan, seperti infeksi, peradangan, tumor, gangguan fungsi oral, maupun penyakit sistemik yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mulut.

Inspeksi

a. Bibir

Perhatikan warna (adakah sianosis atau pucat), kelembaban, oedema, ulserasi atau pecah-pecah

b. Mukosa oral

Mintalah pasien untuk membuka mulut. Dengan pencahayaan yang baik dan bantuan *tongue spatel*, dilakukan inspeksi mukosa oral. Menilai warna mukosa, pigmentasi, ulserasi, dan nodul. Bercak-bercak pigmentasi pada ras kulit hitam masih dalam batas normal.

c. Gusi dan gigi

Menilai adakah inflamasi, oedema, perdarahan, retraksi atau perubahan warna gusi, gigi tanggal atau hilang,

d. Langit-langit mulut atau palatum

Menilai warna dan bentuk langit-langit mulut, adakah torus palatinus.

e. Lidah

Menilai lidah dan dasar mulut, termasuk warna dan papilla, adakah glossitis, paralisis syaraf kranial ke-12.

f. Faring

Mintalah pasien untuk membuka mulut, dengan bantuan *tongue spatel* lidah kita tekan pada bagian tengah, mintalah pasien mengucapkan "aaa". Perhatikan warna atau eskudat, simetri dari langit-langit lunak. Adakah faringitis, paralisis syaraf kranial ke-10.

F. Pemeriksaan Leher



Gambar 2.5 Leher

Leher merupakan jembatan antara kepala dan bagian tubuh lainnya. Leher terletak di antara mandibula dan klavikula, yang menghubungkan kepala langsung ke batang tubuh dan berisi banyak struktur vital. Pemeriksaan leher adalah prosedur medis yang dilakukan untuk menilai kondisi struktur di leher, termasuk kelenjar getah bening, kelenjar tiroid, pembuluh darah, otot, dan trakea. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi kelainan seperti infeksi, pembengkakan kelenjar, gangguan tiroid. Melakukan pemeriksaan leher, meliputi: regio colli, trachea, kelenjar tiroid, dan kelenjar limfonodi.

1. Regio Colli

a. Inspeksi

Inspeksi pada leher untuk melihat adanya asimetri, denyutan abnormal, tumor, keterbatasan gerakan dalam *range of motion* (ROM) maupun pembesaran kelenjar limfe dan tiroid.

b. Palpasi

Pemeriksaan palpasi leher dilakukan pada tulang hyoid, tulang rawan tiroid, kelenjar tiroid, muskulus strnokleidomastoideus, pembuluh karotis dan kelenjar limfe. Pemeriksaan dilakukan pada kedua sisi (bilateral) bersamaan.

2. Pemeriksaan Trachea

a. Inspeksi

Inspeksi trachea untuk melihat adanya deviasi trachea, simetris, asimetris.

b. Palpasi

Palpasi trachea dilakukan dengan cara ujung jari telunjuk dan jari manis menekan pada daerah *m.sternocleidomastoideus* kanan dan kiri dengan trachea dan pasien diminta menelan ludah. Bandingkan pada kedua sisi. Bila kedua jari tangan bisa masuk maka posisi trachea normal, tetapi bila salah satu jari ada yang terhalang masuk, artinya ada deviasi ke arah sisi ini. Massa di leher atau mediastinum akan mendorong trachea ke salah satu sisi. Deviasi trachea juga disebabkan oleh adanya kelainan dirongga dada, seperti atelectasis, massa tumor paru atau pneumothorak yang luas.

3. Pemeriksaan Kelenjar Limfonodi

a. Inspeksi

Inspeksi dilakukan untuk melihat adanya pembesaran, peradangan pada limfonodi seperti penyakit tuberculosis, limfoma maligna, metastase, HIV/AIDs.

b. Palpasi

Pada keganasan kelenjar getah bening, terutama limfoma, dinilai kelenjar mana saja yang membesar, multiple atau tunggal, permukannya, *mobile* atau terfiksasi, konsistensi, nyeri tekan atau tidak, adakah luka pada kelenjar tersebut. Limfadenopati yang hanya berukuran kecil, *discrete* dan *mobile* dapat bersifat fisiologis. Adanya nyeri tekan menunjukkan inflamasi. Limfadenopati yang keras pada palpasi dan terfiksasi mengindikasikan keganasan.

4. Pemeriksaan kelenjar tiroid

a. Inspeksi

Inspeksi kelenjar tiroid dilakukan dari posisi depan untuk menilai apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid, derajat pembesaran tiroid, dan tanda inflamasi.

b. Palpasi

Pemeriksaan palpasi kelenjar tiroid dimulai dari depan, kemudian juga dari belakang pasien. Pemeriksaan dari depan, tiroid dipalpasi adakah pembesaran atau tidak. Kemudian pasien diminta menelan ludah untuk menilai apakah kelenjar tiroid teraba atau tidak, bergerak atau tidak. Bila terjadi pembesaran tiroid, dinilai ukurannya, konsistensi, permukaan (noduler/difus), nyeri tekan, mobilitasnya. Pemeriksaan kelenjar tiroid dari belakang, pasien diminta duduk, pemeriksa berada di belakang kemudian diraba dengan jari-jari kedua tangan. Penilaian kelenjar tiroid sama seperti pemeriksaan dari depan. Dalam kondisi normal: tidak terlihat atau teraba.

c. Auskultasi

Auskultasi pada kelenjar tiroid dapat mendeteksi bising sistolik yang mengarahkan adanya penyakit *Graves*.

G. Latihan Soal

1. Pemeriksaan kepala dilakukan terutama dengan teknik ...
A. Inspeksi dan auskultasi
B. Inspeksi dan palpasi
C. Palpasi dan perkusi
D. Perkusi dan auskultasi
2. Kepala normal secara posisi adalah ...
A. Fleksi ke depan
B. Ekstensi ke belakang
C. Tegak lurus pada garis tengah tubuh
D. Miring ke salah satu sisi
3. Ubun-ubun pada dewasa normalnya ...
A. Cembung
B. Cekung
C. Terbuka
D. Menutup
4. Pemeriksaan konjungtiva dilakukan untuk menilai ...
A. Ikterus
B. Anemia
C. Edema
D. Hipertensi
5. Nilai normal tekanan intraokular adalah ...
A. 5–10 mmHg
B. 10–15 mmHg
C. 11–21 mmHg
D. 20–30 mmHg
6. Tes Rinne positif menunjukkan ...
A. Tuli konduktif
B. Tuli sensorineural
C. Gangguan keseimbangan
D. Infeksi telinga tengah
7. Pada tes Weber, lateralisasi ke telinga sakit menunjukkan ...
A. Tuli sensorineural
B. Tuli konduktif
C. Normal
D. Presbikusi
8. Pemeriksaan hidung bertujuan menilai, kecuali ...
A. Septum nasi
B. Turbinat
C. Refleks pupil
D. Sekret hidung
9. Ucapan “aaa” saat pemeriksaan faring bertujuan menilai ...
A. Saraf kranial V
B. Saraf kranial VII
C. Saraf kranial IX dan X
D. Saraf kranial XII
10. Deviasi trakea umumnya disebabkan oleh ...
A. Kelainan rongga dada
B. Gangguan neurologis
C. Hipotermia
D. Infeksi saluran napas atas

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN FISIK KEPALA DAN LEHER	
Pengertian	Melakukan pemeriksaan/pengkajian fisik secara lengkap
Tujuan	1. Menegakkan diagnosa 2. Mengenali kelainan pada klien 3. Sebagai data dasar
Persiapan Alat/Bahan	1. <i>Handscoon</i> non steril 2. <i>Penlight</i> 3. Metlin 4. Stetoskop 5. Spekulum hidung 6. Otokop 7. <i>Slip lamp</i> 8. <i>Tongue spatel</i> 9. Kasa 10. Bengkok 11. Buku catatan 12. Pena
Prosedur Tindakan	Tahap Persiapan: 1. Justifikasi identitas klien (nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis) 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan 3. Lakukan cuci tangan Komunikasi Terapeutik: 1. Perkenalkan diri 2. Jelaskan pada klien tujuan tindakan yang akan dilakukan 3. Jaga privasi klien dan atur lingkungan sekitar klien 4. Bantu klien untuk mengatur posisi senyaman mungkin Tahap Kerja Pemeriksaan Kepala 1. Posisikan klien duduk bila mampu, kepala tegak lurus (lepas jika ada rambut palsu) 2. Tanyakan kepada klien: apakah rambut mudah rontok? Apakah ada perubahan warna saat penggunaan <i>shampoo</i>? Apakah sedang melaksanakan kemoterapi? 3. Amati penyebaran, ketebalan, tekstur dan lubrikasi

BAB 3

Pemeriksaan Thorax

A. Pengertian Pemeriksaan Thorax

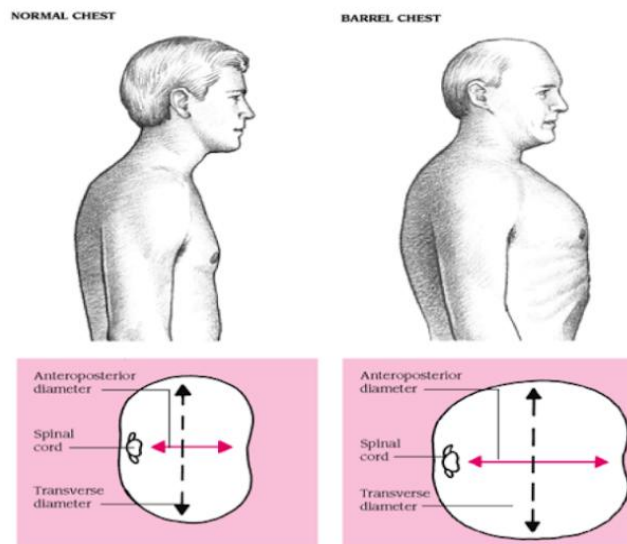
Pemeriksaan thorax merupakan pemeriksaan yang mencakup area dada. Rongga dada atau biasa disebut Thorax merupakan tempat berbagai organ vital bagi manusia, rangka dada ini di lindung oleh tulang iga, atau biasa disebut Ribs, tulang-tulang ini terdiri dari 12 bagian, yaitu 7 buah iga sejati, 3 buah iga palsu, dan 2 buah iga melayang. Pada organ pernafasan yaitu paru-paru, terdapat berbagai bagian yang berada di dalam paru-paru, antara lain: apex, sinus costoprenicus, bronkus, bronkiolus, dan alveolus.

B. Pemeriksaan Fisik Paru-Paru

1. Inspeksi

Pada tahap inspeksi, aspek yang perlu diperhatikan meliputi dimensi statis toraks, yaitu bentuk dan ukuran toraks (diameter lateral serta anteroposterior), kesimetrisan dinding dada, adanya deformitas, serta pola pergerakan dinding dada saat bernapas. Perlu dinilai apakah terdapat retraksi dinding dada yang tidak normal, perbedaan pergerakan antar sisi, atau gerakan yang simetris. Perubahan bentuk toraks dapat terjadi akibat kelainan pada rangka dada, seperti pigeon chest, funnel chest dengan Harrison's groove, rachitic rosary, dada datar, lordosis, maupun kifosis. Proses patologis tertentu dapat menyebabkan penurunan volume kavum toraks, seperti pada fibrosis, atelektasis, agenesis, dan Schwarte; peningkatan volume, seperti pada efusi pleura, pneumotoraks, atau tumor paru; atau tidak menimbulkan perubahan volume, seperti pada konsolidasi paru.

Pada anak-anak, bentuk toraks umumnya hampir silindris (*barrel chest*). Pada dewasa muda, diameter anteroposterior biasanya lebih kecil dibandingkan diameter lateral, sedangkan pada usia lanjut bentuk toraks kembali mendekati silindris. Penting untuk diingat bahwa pengamatan terhadap sisi pergerakan pernapasan dapat membantu menentukan lokasi kelainan, karena sisi toraks yang tertinggal dalam pergerakan merupakan sisi yang mengalami proses patologis. Sebagai contoh, apabila sisi kanan tampak lebih besar dan pergerakannya tertinggal, hal ini menunjukkan adanya kelainan di sisi kanan berupa peningkatan volume. Sebaliknya, jika sisi kanan lebih besar namun pergerakan pernapasan sisi kiri tertinggal, dapat disimpulkan adanya kelainan pada sisi kiri yang ditandai dengan penurunan volume.



Gambar 3.1 Perbandingan Dada Normal dengan *Barrel Chest*

Frekuensi pernapasan normal berkisar 16–20 kali per menit. Tipe pernapasan pada laki-laki dan anaka-anak adalah tipe torakoabdominal, yaitu pergerakan pernapasan terutama thorax bagian bawah dan abdomen bagian atas. Tipe pernapasan pada wanita adalah torakal, yaitu pergerakan pernapasan terutama thorax bagian atas. Frekuensi napas dihitung selama 30 detik, kemudian dikalikan dengan angka 2. Frekuensi napas dewasa normal berkisar 12 hingga 20 kali per menit. Frekuensi napas bervariasi bergantung pada beberapa faktor, diantaranya yaitu usia dan derajat aktivitas. Takipnea merupakan peningkatan frekuensi pernapasan persisten lebih dari 20 kali per menit sedangkan bradipnea bila frekuensi pernapasan dibawah 20 kali per menit. Takipnea dapat ditemukan pada pasien dengan asites masif atau pembesaran hepar. Pola napas ini terjadi sebagai respons terhadap hambatan penurunan diafragma pada kedua kondisi tersebut.

Bradipnea dapat ditemukan pada individu dengan gangguan neurologis, gangguan elektrolit, infeksi atau respons sadar untuk mencegah peningkatan nyeri padarongga dada seperti nyeri pleuritik. Lebih lanjut pola pernapasan lain seperti hiperpnea yaitu peningkatan frekuensi dan kedalaman napas yang dapat ditemukan pada pasien asidosis metabolik, juga apnea yaitu henti napas yang transien.



Gambar 3.2 Pemeriksaan Palpasi Dada (Toraks) pada Pasien

2. Palpasi

Palpasi pada pemeriksaan thoraks mencakup penilaian terhadap tiga aspek utama, yaitu posisi mediastinum, pergerakan pernapasan, serta hantaran getaran suara (fremitus vokal). Selain itu, palpasi juga digunakan untuk menilai permukaan dinding dada guna mendeteksi adanya massa, saluran sinus, nyeri tekan, atau krepitasi yang dapat ditemukan pada emfisema subkutan. Penentuan posisi mediastinum dilakukan melalui palpasi trakea serta identifikasi letak iktus kordis. Dalam kondisi normal, trakea berada di garis tengah, meskipun pada individu usia lanjut dapat sedikit bergeser ke kanan. Pergeseran trakea dari posisi tengah mengindikasikan adanya proses patologis di dalam rongga toraks.

Pada pemeriksaan apeks jantung, lokasi normalnya berada di sela iga (intercostal space/ICS) kelima kiri, di sebelah medial garis midklavikula. Apabila posisi apeks jantung ditemukan lebih lateral atau lebih inferior dari normal, hal tersebut dapat menandakan pembesaran jantung, yang dapat terjadi pada kelainan dinding dada, gangguan pleura, maupun penyakit paru. Jika pulsasi apeks jantung tidak teraba saat pasien dalam posisi terlentang, posisi pasien diubah menjadi left lateral decubitus, kemudian palpasi dilakukan kembali menggunakan beberapa jari. Apabila pulsasi masih belum terdeteksi, pasien diminta menarik napas dalam dan menahannya sejenak. Pada pasien perempuan, jaringan mammae digeser ke atas untuk mempermudah identifikasi apeks jantung. Penentuan lokasi apeks jantung dilakukan dengan ujung jari telunjuk pemeriksa, kemudian dilanjutkan dengan penilaian amplitudo dan durasi denyutnya. Durasi pulsasi apeks jantung

dapat dievaluasi menggunakan stetoskop, di mana secara normal pulsasi berlangsung sekitar dua pertiga fase sistolik dan tidak berlanjut hingga bunyi jantung kedua (S2).

Terdapat beberapa tipe pulsasi apeks abnormal sebagai berikut:

- a. *Pressure loaded apex beat*: jika pulsasi apeks jantung teraba besar dan kuat
- b. *Volume loaded (thrusting displaced) apex beat* : impuls difus dan tidak terus menerus (biasanya muncul pada regurgitasi mitral lanjut dan kardiomiopati dilatasi)
- c. *Double impulse apex beat*: impuls ganda pada apeks jantung yang teraba pada saat sistolik (tanda khas kardiomiopati hipertrofi)
- d. *Tapping apex beat*: teraba pada saat S1 (orang normal tidak teraba), mengindikasikan stenosis mitral atau pada stenosis tricuspid (sangat jarang)
- e. *Dyskinetic apex beat*: impuls yang tak terkoordinasi yang dapat dirasakan pada area luas di prekordium dan biasanya dikarenakan disfungsi ventrikel kiri misalnya infark miokard anterior.



Gambar 3.3 Pemeriksaan Ekspansi Dada Posterior melalui Palpasi

Pada kondisi tertentu apeks jantung tidak teraba. Hal tersebut terjadi pada dinding dada yang tebal, emfisema, efusi perikardial, syok dan jarang pada malposisi jantung (dekstrokardia) yang teraba pada dada bagian kanan. Pada keadaan pembesaran ventrikel kanan atau pembesaran atrium kiri yang berat dimana ventrikel kanan terletak lebih anterior maka pulsasi teraba pada dinding dada pada saat sistolik.



Gambar 3.4 Pemeriksaan Fremitus Taktil pada Toraks Posterior

Palpasi untuk menilai gerakan pernapasan atau pergerakan dinding dada dapat dilakukan dengan meletakkan kedua telapak tangan pada kedua hemitoraks sembari merasakan dan mengamati apakah dada bergerak/bereksansi secara simetris atau tidak. Penilaian kesimetrisan paru pada palpasi merupakan kelanjutan atau konfirmasi dari tindakan inspeksi pergerakan dada sebelumnya. Selain itu, perhatikan pula pola pernapasan dan gerakan lobus-lobus paru serta diafragma. Getaran suara yang timbul pada dinding thorax akibat hantaran getaran suara melalui bronkus dan parenkim paru disebut fremitus vokal. Getaran ini dapat didengar dengan stetoskop (fremitus dengar) dan dapat pula diraba (fremitus raba).

Fremitus raba perlu dinilai dengan cara membandingkan area dada yang simetris. Keadaan fremitus raba dapat berada dalam batas normal, meningkat, menurun, atau bahkan tidak teraba sama sekali. Untuk mendeteksi adanya gesekan pleura saat inspirasi, sisi ulnar telapak tangan ditempatkan pada area yang terasa nyeri. Pemeriksaan vocal fremitus dapat dilakukan menggunakan sisi ulnar tangan maupun permukaan palmar. Fremitus umumnya lebih jelas teraba pada laki-laki dibandingkan perempuan, karena suara dengan frekuensi rendah lebih sesuai dengan resonansi alami rongga toraks. Pada anak-anak, fremitus cenderung lebih menonjol karena dinding dada anak memiliki frekuensi alami yang lebih tinggi, sehingga mendekati frekuensi suara anak yang juga lebih tinggi.

3. Perkusi Paru

Perkusi adalah menentukan densitas (kepadatan) jaringan paru yaitu perbandingan jaringan padat dengan udara. Perkusi dilakukan dengan cara jari tengah bagian volar tangan kiri sebagai pleksimeter (landasan perkusi), ujung jari tengah tangan kanan sebagai pleksor (alat pemukul).

Cara perkusi sebagai berikut :

- a. Hiperekstensi jari tengah pada tangan kiri, yang dikenal dengan *pleximeter finger*.



Gambar 3.5 Pleximeter Finger

- b. Posisikan tangan kanan cukup dekat dengan permukaan daerah lokasi perkusi sebagian dan rileks.



Gambar 3.6 Perkusi Toraks Secara Langsung

- c. Lakukan dengan cepat dan tepat, tetapi pergelangan tangan tetap dalam keadaan rileks.
- d. Ketuk dengan menggunakan ujung fleksor jari, bukan menggunakan bantalan jari.
- e. Lakukan gerakan withdraw atau melepas dengan cepat setelah melakukan ketukan sekali untuk menghindari redaman getaran akibat ketukan.

Nada perkusi ini hanya menembus sedalam 5–7 cm dan resonansi nada ini merupakan fungsi kepadatan jaringan. Jaringan yang mengandung udara lebih resonan daripada jaringan padat. Nada tersebut mungkin berbeda dari tiap-tiap orang, namun harus sama di kedua sisi dada yang sama dari seseorang. Suara yang timbul akibat perkusi dapat dikelompokkan menjadi timpani, hipersonor, sonor, redup dan pekak. Perkusi juga dapat menentukan batas-batas paru-hepar dan paru-jantung serta peranjakan diafragma.

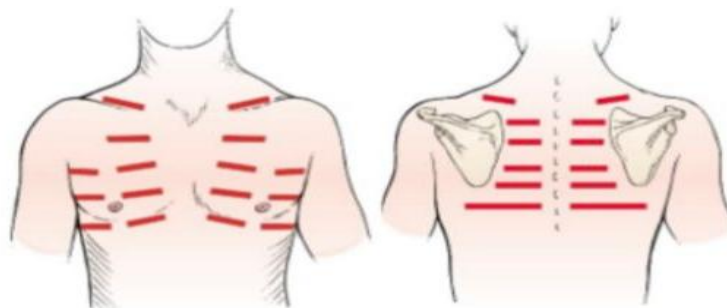
Perkusi paru dilakukan terutama pada area thoraks posterior. Sementara itu, perkusi pada thoraks anterior mencakup daerah fossa supraklavikula, aksila, serta sela iga bagian depan. Teknik perkusi dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil antara hemitoraks kanan dan kiri. Pada thoraks posterior, perkusi dilakukan di area atas skapula, di antara kedua skapula, dan di bawah skapula pada ruang antariga, dengan pengecualian area skapula yang tidak dilakukan perkusi. Pemeriksa sebaiknya melakukan pemeriksaan secara sistematis dari bagian kranial ke kaudal sambil membandingkan sisi kanan dan kiri untuk memperoleh hasil yang akurat.

Berikut merupakan macam-macam suara perkusi:

Tabel 3.1 Macam-Macam Suara Perkusi

Suara Perkusi	Nada	Durasi	Patologi Anatomi
Pekak	Lebih tinggi	Lebih pendek	Padat (cair), udara (-)
Redup	Tinggi	Pendek	Udara < normal
Sonor	Normal	Normal	Normal (padat = Udara)
Hipersonor	Rendah	Panjang	Udara > normal
Timpani	Lebih rendah	Lebih lama	Udara saja

4. Auskultasi



Gambar 3.7 Titik Auskultasi Sistem Pernapasan pada Toraks

Proses ini biasanya melibatkan empat area utama, yaitu lobus atas, tengah, dan bawah dari kedua paru-paru di bagian depan, belakang, serta sisi tubuh.

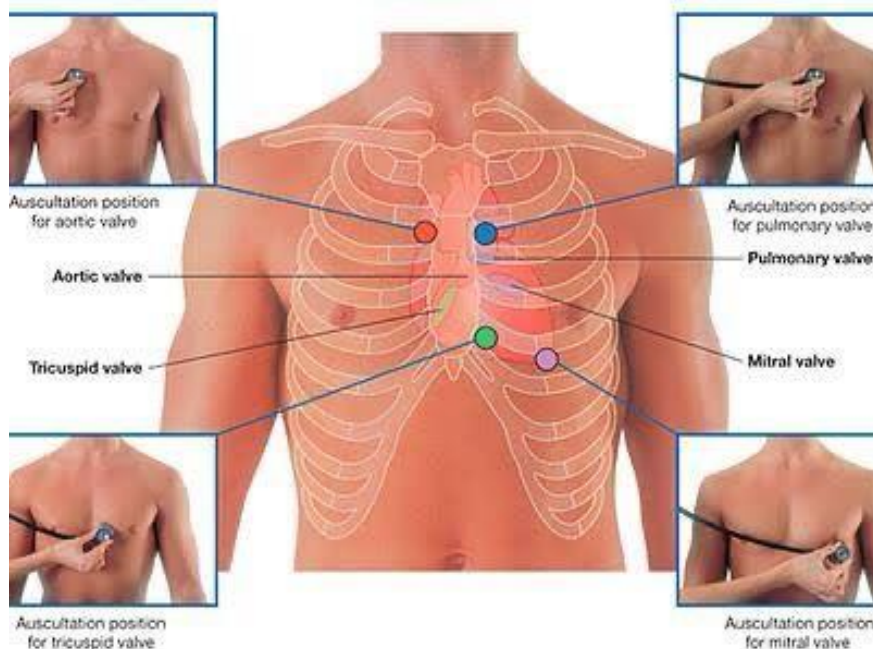
Berikut adalah jenis suara yang umum terdengar selama pemeriksaan.

- Ronchi: Suara rendah yang biasanya menunjukkan adanya sekresi atau lendir di saluran pernapasan besar.
- Mengi: Suara siulan bernada tinggi, sering terkait dengan penyempitan saluran pernapasan, seperti pada asma.
- Krepitasi (crackles/rales): Suara gemericik atau letupan kecil yang mungkin menandakan cairan atau fibrosis di jaringan paru.
- Suara pleura: Dapat menunjukkan adanya gesekan pleura atau inflamasi pada lapisan luar paru.

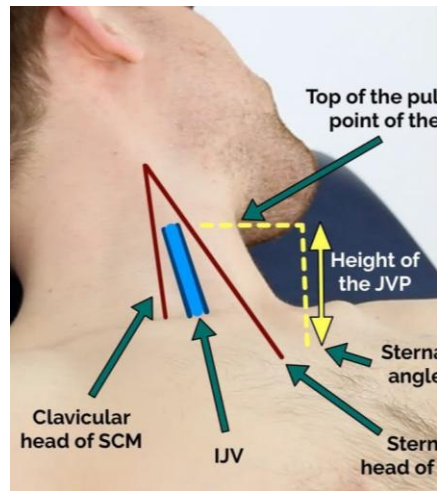
C. Pemeriksaan Fisik Jantung

Sistem kardiovaskular berperan utama dalam mendistribusikan oksigen, zat gizi, serta berbagai substansi penting lainnya ke seluruh jaringan tubuh, sekaligus mengeluarkan produk sisa metabolisme menuju ginjal dan paru-paru. Oleh karena itu, pemeriksaan pada sistem ini harus dilakukan secara tepat, teliti, dan sistematis. Auskultasi jantung merupakan komponen krusial dalam pemeriksaan kardiovaskular. Kemampuan untuk mengenali dan membedakan bunyi jantung normal dan tidak normal memerlukan keterampilan serta latihan yang memadai agar hasil pemeriksaan dapat diinterpretasikan secara akurat.

Pemeriksaan pada area leher, khususnya untuk mengamati vena jugularis, dapat memberikan informasi penting mengenai aktivitas jantung. Perubahan fungsi jantung dapat tercermin pada sistem vena melalui peningkatan tekanan vena perifer, terjadinya bendungan vena, serta perubahan pola pulsasi vena. Karena manifestasi perubahan aktivitas jantung pada vena terjadi pada tekanan yang relatif rendah, maka evaluasi terhadap kondisi vena perlu dilakukan secara cermat dan teliti. Vena yang paling mudah diamati dan dinilai adalah vena jugularis. Penilaian tekanan vena perifer umumnya dilakukan dengan mengamati tekanan vena jugularis eksternal.



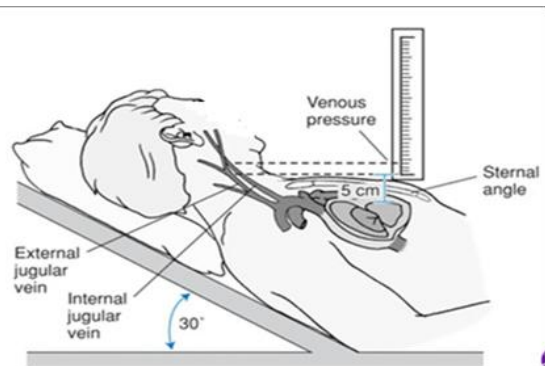
Gambar 3.8 Titik-titik Auskultasi Katup Jantung



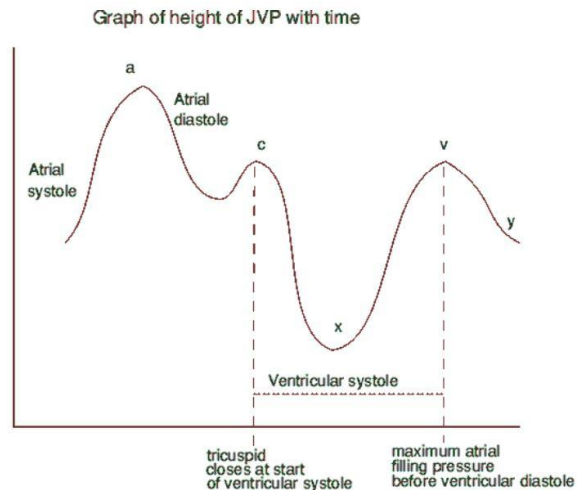
Gambar 3.8 Pemeriksaan Fisik Vena Jugularis untuk menilai Tekanan Vena Jugularis (JVP)

Penilaian tekanan vena jugularis dapat mengalami kendala apabila terjadi peningkatan tekanan intratorakal yang menghambat transmisi tekanan vena dari jantung. Kondisi tersebut dapat terjadi saat tertawa, sesak napas, batuk, menangis, mengejan, melakukan manuver Valsalva, serta pada pasien dengan emfisema, struma, atau adanya sklerosis vena jugularis akibat faktor usia, pascakanulasi, dan kondisi lainnya.

Pengukuran tekanan vena jugularis dilakukan secara tidak langsung dengan menentukan titik nol atau level flebostatik, yaitu titik yang merepresentasikan posisi tengah atrium kanan. Titik ini diperkirakan berada pada perpotongan garis midaksilaris dengan garis vertikal sternum pada tingkat angulus Ludovici. Pada posisi berdiri, tekanan vena jugularis normal biasanya tidak tampak karena berada di dalam rongga toraks. Dalam posisi berbaring, vena jugularis dapat terisi meskipun tekanan vena masih dalam batas normal. Pada posisi setengah duduk dengan sudut 45 derajat dalam keadaan rileks, pertemuan vena jugularis dengan klavikula berada sekitar 5 cm di atas titik nol. Apabila batas atas pulsasi vena terlihat melewati klavikula, hal tersebut menandakan adanya peningkatan tekanan vena jugularis.



Gambar 3.9 Pengukuran Tekanan Vena Jugularis (Jugular Venous Pressure/JVP)



Gambar 3.10 Kurva Tekanan Vena Jugularis (Jugular Venous Pulse/JVP) selama Siklus Jantung

Pada kondisi gagal jantung, tekanan vena jugularis akan meningkat sebagai akibat terhambatnya pengisian ventrikel. Pada fase awal gagal jantung, dapat terjadi konstiksi vena sebelum peningkatan tekanan vena secara nyata. Manifestasi ini dapat dinilai melalui uji refluks hepatojugular, yang dilakukan dengan membiarkan pasien bernapas normal, kemudian memberikan tekanan pada area di bawah arkus kosta kanan. Penekanan tersebut menyebabkan pergeseran darah dari hepar sehingga meningkatkan tekanan vena jugularis. Pulsasi vena dapat terlihat terutama pada vena jugularis eksterna dan interna. Karena tekanannya yang rendah, pulsasi ini tak teraba namun dapat terlihat pada bagian atas dari kolom darah yang mengisinya. Seperti juga pulsus atrium, terdapat tiga komponen dari pulsus vena yaitu gelombang a disebabkan karena aktivitas atrium, gelombang c karena menutupnya katup trikuspid, serta gelombang v yang merupakan desakan katup waktu akhir sistol ventrikel.

Beberapa gambaran abnormalitas JVP antara lain cannon a-waves atau peningkatan amplitudo gelombang a, seperti pada kasus disosiasi AV (AV blok total), dimana kontraksi atrium menghadapi katup trikuspid yang menutup, hal ini juga dapat terjadi pada takikardia ventrikel atau fibrilasi ayrium. Peningkatan JVP merupakan tanda klasik hipertensi vena (gagal jantung kanan). Peningkatan JVP dapat dilihat sebagai distensi vena juguler.

Yang harus dinilai bila terdengar bising jantung adalah kapan terdengar, bentuk, lokasi di mana bising terdengar paling keras, radiasi/ transmisi bising dari tempatnya paling keras terdengar, intensitas bising, nada dan kualitas bising.

1. Kapan Bising Terdengar

Metode Penentuan Fase Jantung Untuk membedakan antara fase sistolik dan diastolik, palpasi nadi karotis dapat dilakukan secara bersamaan dengan auskultasi. Bising yang muncul bertepatan dengan denyutan nadi karotis diklasifikasikan sebagai bising sistolik. Secara klinis, bising sistolik dapat ditemukan pada jantung normal maupun yang mengalami kelainan anatomi, sedangkan bising diastolik hampir selalu mengindikasikan gangguan pada katup.

a. Klasifikasi Bising Sistolik

Bising ini terdengar di antara Bunyi Jantung 1 (BJ1) dan Bunyi Jantung 2 (BJ2).

- 1) *Midsistolik*: Dimulai setelah BJ1 dan berakhir sebelum BJ2 (terdapat jeda). Biasanya berhubungan dengan aliran darah melalui katup semilunaris (stenosis aorta atau pulmonal).
- 2) *Holosistolik* (Pansistolik): Mengisi seluruh fase sistolik tanpa jeda. Umumnya berkaitan dengan regurgitasi katup atrioventrikular (seperti Mitral Insufficiency/MI) atau *Ventricle Septum Defect* (VSD).
- 3) *Late Systolic* (Sistolik Akhir): Muncul di pertengahan atau akhir fase sistolik, sering didahului oleh *click* sistolik. Kondisi ini khas pada prolaps katup mitral.

b. Klasifikasi Bising Diastolik

Bising ini terdengar di antara Bunyi Jantung 2 (BJ2) dan Bunyi Jantung 1 (BJ1).

- 1) *Early Diastolic* (Diastolik Awal): Muncul segera setelah BJ2 tanpa jeda dan menghilang sebelum BJ1. Umumnya disebabkan oleh insufisiensi katup semilunaris (Aorta atau Pulmonal).
- 2) *Mid Diastolic*: Terdengar setelah BJ2 (ada jeda) dan biasanya melemah atau menyatu dengan fase berikutnya.
- 3) *Late Diastolic* (Presistolik): Muncul di akhir fase diastolik dan berlanjut hingga BJ1.

Bising mid-diastolik dan late-diastolik sering kali mencerminkan turbulensi aliran darah pada katup atrioventrikular, seperti pada kasus stenosis mitral.

c. Bising Menerus (*Continuous Murmur*)

Bising ini terdengar tanpa henti di kedua fase (sistolik dan diastolik). Kondisi ini merupakan ciri khas dari *Patent Ductus Arteriosus* (PDA).

2. Bentuk

Bentuk atau konfigurasi bising adalah intensitas bising dari waktu ke waktu selama terdengar.

- a. *Bising crescendo*: intensitas makin keras (misalnya bising presistolik pada stenosis mitral).
- b. *Bising decrescendo* intensitas makin berkurang (misalnya bising early diastolic pada regurgitasi katub aorta).
- c. *Bising crescendo-decrescendo* mula-mula intensitas bising makin meningkat, kemudian menurun (misalnya bising midsistolik pada stenosis aorta atau bising innocent).
- d. *Bising plateau* intensitas bising tetap (misalnya bising pansistolik pada regurgitasi mitral).

3. Lokasi dimana Bising Terdengar Paling Keras

Lokasi bising yang terdengar paling jelas umumnya mencerminkan sumber asal bising tersebut. Deskripsi dilakukan dengan menyebutkan sela iga tertentu serta hubungannya dengan struktur anatomi seperti sternum, apeks, linea midsternalis, midklavikularis, atau aksilaris, baik pada sisi anterior maupun lainnya. Contohnya, "bising yang paling jelas terdengar pada sela iga kedua kanan di dekat tepi sternum menunjukkan bahwa bising tersebut berasal dari katup aorta".

4. Radiasi/Transmisi Bising dari Tempatnya Terdengar Paling Keras

Transmisi bising tidak hanya memberikan gambaran mengenai sumber asal bising, tetapi juga mencerminkan derajat intensitas serta arah aliran darah. Oleh karena itu, auskultasi perlu dilakukan pada beberapa area di sekitar titik tempat bising terdengar paling jelas untuk menentukan sejauh mana bising tersebut masih dapat dideteksi. Sebagai contoh, pada stenosis aorta, bising dapat terdengar hingga ke daerah leher karena mengikuti arah aliran darah.

5. Intensitas Bising

Intensitas bising jantung diklasifikasikan ke dalam enam tingkat gradasi dan dinyatakan dalam bentuk pecahan, misalnya grade 2/6.

Grade 1: menunjukkan bising yang sangat lemah, hanya dapat didengar setelah pemeriksa berkonsentrasi penuh dan tidak terdengar pada semua posisi.

Grade 2: merupakan bising lemah namun langsung terdengar saat stetoskop ditempatkan pada area auskultasi.

Grade 3: menggambarkan bising dengan intensitas sedang hingga cukup keras.

Grade 4: adalah bising keras yang disertai getaran teraba (thrill).

Grade 5: menunjukkan bising sangat keras dengan thrill, dan masih dapat terdengar meskipun sebagian stetoskop diangkat dari permukaan auskultasi.

Grade 6: merupakan bising yang sangat keras, disertai thrill, dan tetap terdengar meskipun seluruh bagian stetoskop sedikit diangkat dari permukaan auskultasi.

6. Nada: dikategorikan sebagai nada tinggi, sedang dan rendah.

7. Kualitas bising: kualitas bising dideskripsikan sebagai Dowing harsh, rumbling, dan musikal

Karakteristik yang lain yang harus dinilai dari bunyi jantung dan bising adalah pengaruh perubahan posisi tubuh, respirasi atau manuver pemeriksaan terhadap bunyi jantung dan bising. Bising yang berasal dari sisi kanan Jantung biasanya cenderung berubah bila ada perubahan posisi pasien. Sehingga deskripsi lengkap pelaporan bising adalah sebagai berikut misalnya pada regurgitasi aorta "pada auskultasi terdengar bising decrescendo dengan kualitas bising seperti tupan (blowing), terdengar paling keras pada sela iga ke-4 kiri, dengan penjaran ke arah apeks".

Berikut tindakan pemeriksaan fisik jantung:

Tabel 3.2 Tindakan Pemeriksaan Fisik Jantung

TINDAKAN	RASIONAL
1) Lakukan palpasi pada area arteri karotis kiri dan kanan (lakukan Teknik ini dalam waktu singkat dan hanya dilakukan satu kali saja). Gunakan stetoskop untuk auskultasi arteri.	Palpasi di daerah ini bertujuan untuk mengevaluasi sirkulasi darah melalui arteri. Meraba kedua arteri sekaligus dapat menghambat aliran darah ke otak. Auskultasi dapat mendeteksi bruit (suara yang terjadi di dalam pembuluh darah akibat turbulensi, penumpukan plak atau kerusakan pada pembuluh darah)
2) Lakukan inspeksi pada leher pasien untuk mengetahui apakah ada distensi jugularis. Amati apakah ada denyut di bagian tersebut.	Teknik ini membantu mendeteksi adanya tekanan jantung di sisi kanan

3) Pemeriksaan precordium pasien dengan mengamati impuls apical di intercostal ke-4 hingga ke-5 (ICS)	Inspeksi precordium membantu mendeteksi denyut nadi. Umumnya tidak ada denyutan kecuali impuls apical
4) Palpasi intercostal ke-4 hingga ke-5 dengan menggunakan telapak tangan dengan Teknik keempat jari disatukan untuk merasakan adanya denyutan (suhu telapak tangan pemeriksa harus hangat). Palpasi dilakukan secara sistematis, meliputi: aorta, pulmo, tricuspid, dan area mitral serta titik Erb. Palpasi impuls apical di daerah mitral. Catat ukuran, durasi, kekuatan, dan lokasi sehubungan dengan garis midclavicular.	Pemeriksaan ini membantu mengidentifikasi setiap seensasi precordial, adanya getaran yang deras di atas ICS kedua kanan atau kiri, dan setiap pengangkatan atau penurunan di perbatasan tulang dada Ketika setiap jantung berdetak. Normalnya tidak ada denyutan teraba di atas aorta dan pulmonal.
5) Lakukan auskultasi secara sistematis mulai dari area aorta dengan menggunakan stethoscope, pindah ke aera pulmonalik, lalu di titik Erb, kemudian ke daerah tricuspid, dan berakhir di daerah mitral. Instruksikan pasien untuk bernafas secara normal Ketika pemeriksaan sedang berlangsung.	Auskultasi bertujuan untuk mengevaluasi denyut dan irama jantung serta menilai suara normal (lub + S1; dub = S2) dan suara jantung abnormal (S3 dan S4). Bunyi jantung normal (S1 dan S2) dihasilkan oleh penutupan katup (Aorta, pulmonalik, tricuspid, mitral). S3 bisa menjadi temuan normal pada Wanita hamil pada trimester ketiga karena peningkatan curah jantung.
6) Fokus pada laju dan ritme jantung secara keseluruhan dan bunyi jantung normal dengan menggunakan stethoscope. Instruksi pasien untuk Kembali menggunakan baju.	Fungsi dari stethoscope adalah untuk mendengarkan suara bernada tinggi dan suara bernada rendah.

D. Pemeriksaan Fisik Payudara

Selama pemeriksaan, sangat penting memastikan pasien berada dalam kondisi nyaman mungkin. Pemeriksa perlu menjelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Tangan pemeriksa serta suhu ruangan sebaiknya dalam keadaan hangat, dan ruang pemeriksaan harus memiliki pencahayaan yang memadai. Apabila pemeriksaan dilakukan oleh dokter laki-laki, sebaiknya didampingi oleh tenaga paramedis perempuan.

1. Inspeksi

Penderita diminta untuk membuka pakaian sampai pinggang dan posisi pasien duduk menghadap ke dokter. Pemeriksaan ini dilakukan dengan 4 posisi yaitu tangan disamping, tangan di atas kepala, tangan dipinggang dan posisi membungkuk.

- a. Perhatikan apakah kedua payudara simetris. Bandingkan bentuk atau kontur dari kedua payudara, ukuran dan isi dari kedua payudara. Letak papilla mammae juga dibandingkan dari kedua payudara. Letaknya biasanya di SIC 4 atau 5 pada linea mid klavikularis untuk penderita pria atau wanita muda. Karena faktor usia atau bila sudah terdapat banyak lemak atau kelenjar susu maka posisi puting menjadi sangat bervariasi.
- b. Dilihat adakah nodul pada kulit yang berbentuk seperti papula yang dapat merupakan nodul satelit pada keganasan. Bila ada, dilihat bagaimana bentuknya, berapa jumlahnya, dimana letaknya, warnanya
- c. Adakah perubahan warna? Perubahan warna kemerahan menunjukkan adanya peningkatan aliran darah sekunder yang disebabkan oleh inflamasi. Dapat juga disebabkan karena pertumbuhan keganasan pada kulit atau infiltrasi tumor pada kulit.
- d. Adakah luka/borok. Erosi pada aerola atau papilla mammae (puting payudara) biasanya akan tertutup oleh krusta sehingga bila krusta diangkat baru akan terlihat kulit yang mengalami erosi. Erosi pada aerola karena kelainan kulit biasanya melibatkan kedua sisi sedangkan pada keganasan atau Paget's disease biasanya hanya satu sisi.
- e. Adakah bengkak pada kulit? Bengkak yang disebabkan karena infeksi dan sumbatan saluran limfe secara mekanis akan memberikan bentuk yang berbeda. Sumbatan karena mekanis atau limfedema akan memberikan gambaran peau d'orange atau orange peel atau pig skin. Biasanya karena adanya infiltrasi keganasan pada limfonodi atau jalur limfnya.
- f. Perlu diperhatikan apakah terdapat tarikan kulit (*dimpling*). Inspeksi dilakukan dengan posisi pasien duduk dan kedua lengan diangkat ke atas kepala. Pada posisi ini, pemeriksa menilai adanya fiksasi kulit atau puting pada kelenjar payudara serta kemungkinan perubahan atau distorsi bentuk payudara akibat massa yang terfiksasi. Dimpling dapat terjadi apabila kanker telah menginfiltrasi ligamentum suspensorium Cooper sehingga menimbulkan tarikan pada permukaan kulit payudara. Temuan ini merupakan salah satu tanda yang mengarah pada keganasan, meskipun dapat pula

disebabkan oleh kondisi lain seperti riwayat trauma, jaringan parut pascaoperasi, atau bekas infeksi sebelumnya.

Metode inspeksi tambahan dapat dilakukan dengan meminta pasien membungkuk ke depan pada daerah pinggang (*bending position*), dengan badan, dagu, dan bahu mengarah ke depan. Pada posisi ini, adanya lekukan, tarikan kulit, asimetri, atau permukaan kulit yang tidak rata akan tampak lebih jelas.

- g. Pemeriksaan puting payudara: Adanya nipple discharge atau keluarnya cairan dari papilla mammae yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada saat palpasi. Retraksi dari papilla mammae mungkin merupakan pertumbuhan tumor ganas yang telah menginfiltrasi duktus laktiferus yang menjadi retraksi dan fibrosis. Tapi juga perlu diingat bahwa retraksi dapat terjadi secara kongenital (*inverted nipple*), dan biasanya bilateral.

Axilla juga diinspeksi untuk melihat ada tidaknya pembengkakan akibat pembesaran limfonodi karena tumor atau karena infeksi, ditandai dengan adanya perubahan warna kemerahan.



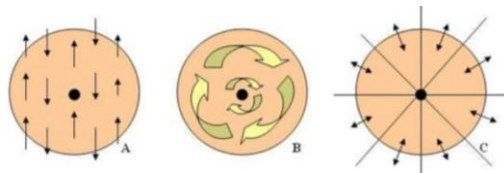
**Gambar 3.11 Kelainan Payudara
pada Pemeriksaan Fisik Dada**

2. Palpasi

Setelah inspeksi menyeluruh pada payudara, daerah aksila, dan supraklavikula selesai dilakukan, pemeriksaan dilanjutkan dengan palpasi. Perlu dipahami bahwa hasil palpasi pada payudara normal dapat sangat bervariasi, sehingga diperlukan waktu serta pengalaman pemeriksa untuk menafsirkannya secara tepat. Struktur kelenjar payudara yang berlobulasi dapat keliru dianggap sebagai massa, demikian pula jaringan lemak subkutan yang dapat memengaruhi temuan palpasi. Selain itu, perubahan fisiologis payudara perlu diperhatikan. Menjelang menstruasi dan selama kehamilan, payudara cenderung membesar, berlobulasi, dan lebih sensitif. Setelah menstruasi, ukuran payudara biasanya mengecil dan konsistensinya menjadi lebih lunak. Pada masa kehamilan, payudara membesar dan terasa lebih keras dengan lobulasi yang nyata, sehingga dapat menyulitkan deteksi massa atau tumor melalui palpasi.

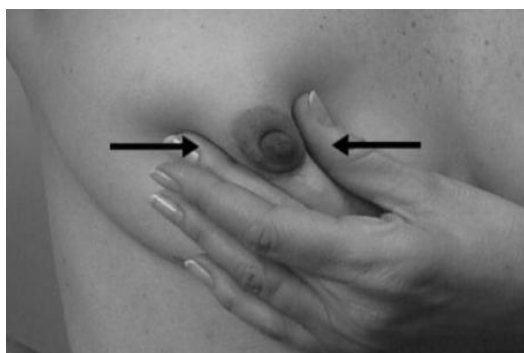
Apabila pasien mengeluhkan adanya benjolan pada salah satu payudara, pemeriksaan tetap harus dilakukan secara lengkap pada kedua payudara. Palpasi sebaiknya dimulai dari sisi yang tidak dikeluhkan atau dianggap sehat terlebih dahulu untuk mencegah terlewatnya kemungkinan kelainan lain:

- Prosedur Pemeriksaan payudara : Pemeriksaan Penderita Berbaring Penderita pada posisi berbaring terlentang dengan bagian belakang dada diganjal menggunakan bantal. Kedua tangan penderita diletakan di atas kepala untuk memudahkan pemeriksaan axilla. Pemeriksaan payudara menggunakan satu tangan dan tangan satunya sebagai penahan.
- Teknik pemeriksaan palpasi payudara bisa menggunakan cara palpasi dengan arah radier yaitu seperti jeruji dari tengah kearah perifer pada seluruh lapang payudara, atau menggunakan arah linier yaitu dari lateral atas ke bawah selanjutnya naik lagi, dari lateral ke medial seperti gambar dibawah.
- Teknik selanjutnya adalah teknik sirkuler. Teknik ini dari lateral atas dari tiap payudara, melingkar searah jarum jam ke arah dalam sampai ke tengah, dilakukan dengan tekanan yang ringan.



Gambar 3.12 Pola Perkusi Toraks dalam Pemeriksaan Fisik Paru

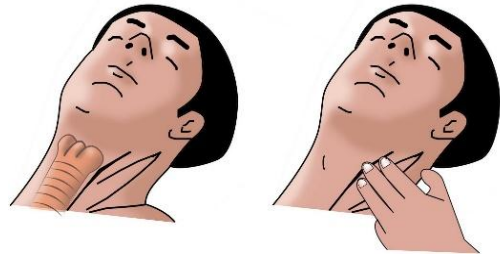
Untuk menentukan massa pada payudara mobile atau terfiksasi, dinilai dengan menggunakan satu tangan. Satu tangan menekan massa perlahan-lahan, bila massa dapat digerakkan atau berkapsul maka massa akan menggelincir menjauh dan menghilang, bila tekanan dihilangkan maka massa akan kembali.



Gambar 3.13 Penilaian Kelainan Puting Susu pada Pemeriksaan Payudara

E. Pemeriksaan Axilla

Pemeriksaan daerah aksila dan supraklavikula dilakukan secara bergantian dengan pasien dalam posisi duduk maupun berbaring. Pada pemeriksaan aksila, pelonggaran fascia aksilaris merupakan hal yang sangat penting. Untuk mencapai kondisi tersebut, lengan pasien perlu disangga atau ditopang oleh tangan pemeriksa pada sisi yang sama, yaitu lengan kiri pasien disangga dengan tangan kiri pemeriksa dan lengan kanan pasien disangga dengan tangan kanan pemeriksa.



Gambar 3.14 Pemeriksaan Palpasi Kelenjar Getah Bening Servikal



Gambar 3.15 Pemeriksaan palpasi kelenjar getah bening supraklavikula

Palpasi dimulai dari bagian lateral atas toraks hingga mencapai apeks aksila. Ketelitian dan kehati-hatian pemeriksa sangat menentukan banyaknya informasi klinis yang dapat diperoleh. Perlu diperhatikan bahwa pada pasien dengan obesitas, hasil palpasi payudara dan aksila cenderung kurang akurat sehingga interpretasinya harus dilakukan dengan lebih hati-hati.

Pemeriksaan limfonodi supraclavicularis sangat tepat bila dilakukan dengan pemeriksa berdiri di belakang penderita. Berapa banyak benjolan, tepi benjolan, keterlibatan dengan jaringan sekitar dan konsistensinya harus dicatat. Pemeriksaan ini dapat mengarahkan diagnosis pembesaran kelenjar ini disebabkan oleh keganasan atau infeksi.

F. Latihan Soal

1. Frekuensi napas normal dewasa adalah ...
A. 8–12 x/menit
B. 10–15 x/menit
C. 12–20 x/menit
D. 20–30 x/menit
2. Takipnea didefinisikan sebagai RR ...
A. < 10 x/menit
B. < 12 x/menit
C. > 20 x/menit
D. > 30 x/menit
3. Bentuk dada barrel chest umumnya ditemukan pada ...
A. Anak-anak
B. Dewasa muda
C. Lansia
D. Bayi prematur
4. Lokasi normal apeks jantung adalah ...
A. ICS 3 kiri
B. ICS 4 kanan
C. ICS 5 kiri garis midklavikula
D. ICS 6 kiri
5. Fremitus vokal meningkat pada kondisi ...
A. Pneumotoraks
B. Efusi pleura
C. Konsolidasi paru
D. Emfisema
6. Suara perkusi hipersonor menandakan ...
A. Cairan
B. Jaringan padat
C. Udara berlebih
D. Normal
7. Bunyi jantung S1 berasal dari...
A. Penutupan katup semilunaris
B. Penutupan katup AV
C. Aliran darah ventrikel
D. Getaran aorta
8. Bising diastolik hampir selalu menunjukkan ...
A. Variasi normal
B. Gangguan katup
C. Gangguan paru
D. Gangguan vaskular
9. Grade 4 bising jantung ditandai oleh ...
A. Sangat lemah
B. Tidak terdengar
C. Disertai thrill
D. Terdengar tanpa stetoskop
10. Patent Ductus Arteriosus ditandai oleh bising ...
A. Sistolik
B. Diastolik
C. Midsistolik
D. Menerus

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN FISIK THORAX	
Pengertian	Melakukan pemeriksaan/pengkajian fisik secara lengkap
Tujuan	1. Menegakkan diagnosa 2. Mengenali kelainan pada klien 3. Sebagai data dasar
Persiapan Alat/Bahan	1. <i>Handscoon</i> non steril 2. <i>Penlight</i> 3. Metlin 4. Stetoskop 5. Otoskop 6. Kasa 7. Bengkok 8. Buku catatan 9. Pena
Prosedur Tindakan	Tahap Persiapan: 1. Justifikasi identitas klien (nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis) 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan 3. Lakukan cuci tangan Komunikasi Terapeutik: 1. Perkenalkan diri 2. Jelaskan pada klien tujuan tindakan yang akan dilakukan 3. Jaga privasi klien dan atur lingkungan sekitar klien 4. Bantu klien untuk mengatur posisi senyaman mungkin Tahap Kerja Pemeriksaan Dada PARU-PARU Inspeksi 1. Posisikan klien senyaman mungkin 2. Secara keseluruhan perhatikan RR, bentuk dan ukuran dada, deviasi, retraksi intercostae dan bentuk tulang belakang 3. Amati dari depan dengan memperhatikan klavikula dan fossa supra/infraklavikula Palpasi 1. Posisikan klien berbaring telentang 2. Palpasi gerakan diafragma/kesimetrisan ekspansi dengan meminta klien menarik nafas dalam 4. Perhatikan terhadap adanya nyeri tekan dan tumor 5. Letakkan sisi ulnar tangan pemeriksa di dada klien 6. Minta klien untuk mengucapkan kata TUJUH... TUJUH...

7. Pemeriksaan dimulai dari dada atas sampai dada bawah
8. Perhatikan intensitas getaran suara dan bandingkan kanan dan kiri

Perkusi

1. Posisikan klien duduk
2. Lakukan perkusi mulai dari fosa klavikula kanan, kemudian dilanjutkan ke dada kiri, selanjutnya perkusi pada supra skapula dada belakang dan dilanjutkan ke bagian dada kiri
3. Lanjutkan lokasi perkusi bergeser ke bawah 2-3 cm, ke bawah sampai batas bawah abdomen
4. Bandingkan suara yang dihasilkan oleh perkusi dada kanan dan kiri

Auskultasi

1. Posisikan klien tetap duduk
2. Tempelkan stetoskop pada dinding dada mulai dari depan diatas klavikula kiri dan teruskan ke sisi dinding dada mulai dari depan diatas klavikula kiri dan teruskan ke sisi dinding dada kanan. Lanjutkan pada scapula dada belakang kiri kemudian ke kanan
3. Minta klien untuk menarik nafas pelan-pelan dengan mulut terbuka
4. Dengarkan satu periode inspirasi dan ekspirasi
5. Geser ke bawah 2-3 cm dan seterusnya sampai ke dada bagian bawah

JANTUNG

Inspeksi

1. Posisikan klien senyaman mungkin (berbaring, telentang)
2. Amati bentuk prekordial (kesimetrisan)
3. Amati denyut apeks jantung dan bayangkan vena di dada

Palpasi

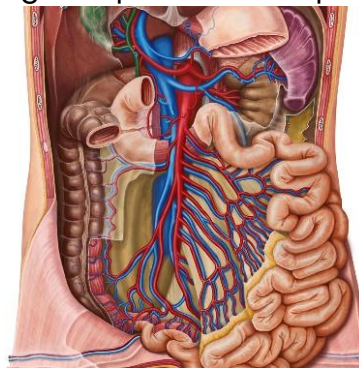
1. Posisikan klien pada posisi supinasi
2. Tentukan sudut Louis (di antara manubrium dan badan sternum)
3. Pindah jari ke bawah sampai ICS 2
4. Tentukan area aorta dan pulmonal (amati adanya pulsasi)
5. Dari area aorta pindah jari secara lateral 5-7 cm ke garis mid klavikula kiri dan tentukan PMI
6. Palpasi pulsasi pada area apikal dan kemungkinan pembesaran

BAB 4

Pemeriksaan Abdomen

A. Anatomi Abdomen

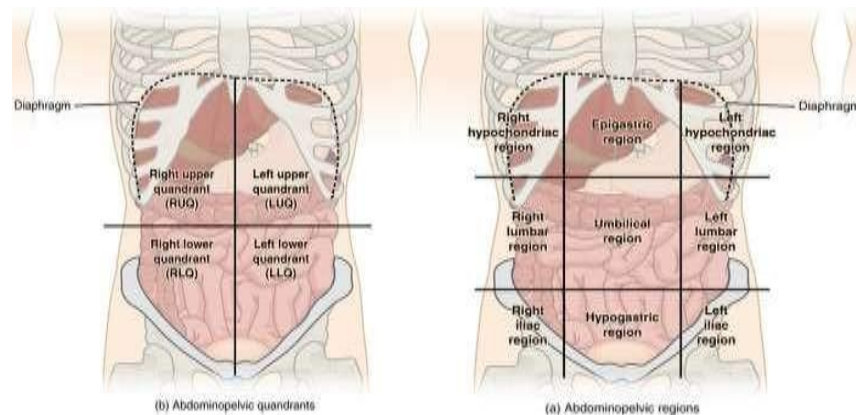
Abdomen merupakan rongga tubuh yang terletak di antara toraks dan pelvis. Rongga ini berisi berbagai organ (visera) yang dilindungi oleh dinding abdomen, tersusun atas otot-otot abdomen, kolumna vertebralis, dan tulang ilium. Abdomen mencakup beberapa sistem utama, yaitu sistem gastrointestinal, sistem perkemihan, dan sistem reproduksi. Sistem pencernaan terdiri atas mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, kolon sigmoid, hingga anus. Organ pencernaan tambahan meliputi gigi, kelenjar saliva, hati, kandung empedu, dan pankreas. Struktur lain yang berkaitan dengan rongga abdomen adalah peritoneum, sistem limfatik, otot dinding abdomen, serta organ reproduksi dan perkemihan.



Gambar 4.1 Anatomi Pembuluh Darah Vena pada Abdomen

Sistem perkemihan tersusun atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berbentuk menyerupai kacang dan terletak di ruang retroperitoneal di sisi kolumna vertebralis. Bagian atas ginjal dilindungi oleh tulang iga terakhir. Ginjal kanan berada sedikit lebih rendah dibanding ginjal kiri karena posisinya di bawah hati. Fungsi ginjal meliputi ekskresi sisa metabolisme, pengaturan keseimbangan kimia serta asam-basa tubuh, produksi renin

dan eritropoetin, serta peran dalam metabolisme vitamin D. Ginjal memerlukan suplai darah yang besar, sekitar 25% dari curah jantung. Untuk menentukan lokasi organ, abdomen dibagi menggunakan dua bidang horizontal dan dua bidang vertikal yang membentuk sembilan regio. Bidang horizontal atas berada setinggi tulang rawan iga kesembilan, sedangkan bidang bawah sejajar dengan bagian atas crista iliaca. Dua bidang vertikal ditarik dari tulang rawan iga kedelapan hingga pertengahan ligamentum inguinale.



Gambar 4.2 Pembagian Abdomen Berdasarkan Kuadran dan Regio

Sembilan regio tersebut meliputi:

1. hypocondriaca dextra meliputi organ: lobus kanan hati, kantung empedu, sebagian duodenum fleksura hepatic kolon, sebagian ginjal kanan dan kelenjar suprarenal kanan
2. Epigastrica meliputi organ: pilorus gaster, duodenum, pankreas dan sebagian hati.
3. Hypocondriaca sinistra meliputi organ: gaster, limpa, bagian kaudal pankreas, fleksura lienalis kolon, bagian proksimal ginjal kiri dan kelenjar suprarenal kiri.
4. Lumbalis dextra meliputi organ: kolon ascenden, bagian distal ginjal kanan, sebagian duodenum dan jejunum.
5. Umumbilical meliputi organ: Omentum, mesenterium, bagian bawah duodenum, jejunum dan ileum.
6. Lumbalis sinistra meliputi organ: kolon ascenden, bagian distal ginjal kiri, sebagian jejunum dan ileum.
7. Inguinalis dextra meliputi organ: sekum, apendiks, bagian distal ileum dan ureter kanan.
8. Pubica/Hipogastric meliputi organ: ileum, vesical urinaria dan uterus (pada kehamilan).
9. Inguinalis sinistra meliputi organ: kolon sigmoid, ureter kiri dan ovarium kiri.

B. Pemeriksaan Fisik

1. Teknik Dasar Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dasar meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Umumnya, teknik ini dilakukan secara berurutan dan sistematis, seperti inspeksi auskultasi perkusi palpasi, namun pada kondisi tertentu urutan pemeriksaan dapat disesuaikan. Faktor usia pasien, terutama bayi, anak-anak, dan lansia, turut memengaruhi urutan dan pendekatan pemeriksaan.

2. Pemeriksaan pada Bayi dan Anak

Pemeriksaan fisik pada bayi dan anak memerlukan pendekatan khusus agar anak tetap tenang, tidak takut, dan kooperatif. Pemeriksaan dilakukan secara terstruktur dan sistematis, meskipun pendekatan sefalokaudal tidak selalu dapat diterapkan secara optimal. Setelah inspeksi umum, dianjurkan melakukan auskultasi abdomen dan jantung terlebih dahulu untuk menilai bising usus serta bunyi jantung, karena tangisan dapat memengaruhi hasil auskultasi. Pemeriksaan kepala dan leher biasanya dilakukan terakhir karena sering menimbulkan ketidaknyamanan pada bayi.

3. Pemeriksaan pada Pasien Geriatrik

Pengkajian pasien lansia bersifat kompleks dan memerlukan waktu lebih lama, bergantung pada kondisi kronis dan kompleksitas masalah yang ada. Secara umum, pemeriksaan fisik serupa dengan pasien dewasa, namun perubahan posisi dilakukan seminimal mungkin. Lingkungan pemeriksaan diupayakan hangat, tenang, dan memiliki pencahayaan yang cukup. Pemeriksa menyesuaikan posisi bila pasien sulit mempertahankan posisi optimal. Pasien diposisikan senyaman mungkin, misalnya setengah duduk pada pasien dengan sesak napas. Pakaian dibuka sesuai kebutuhan pemeriksaan.

4. Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Pemeriksaan Fisik

- Selalu meminta kesediaan/izin pada pasien untuk setiap pemeriksaan.
- Jagalah privasi pasien.
- Pemeriksaan harus seksama dan sistematis.
- Jelaskan apa yang akan dilakukan sebelum pemeriksaan (tujuan, kegunaan, cara dan bagian yang akan diperiksa).
- Beri instruksi spesifik yang jelas.
- Berbicaralah yang komunikatif.
- Ajaklah pasien untuk bekerja sama dalam pemeriksaan.
- Perhatikanlah ekspresi/bahasa nonverbal dari pasien.

5. Definisi Inspeksi dan Cara Pemeriksaan Inspeksi
 - a. Inspeksi adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan menggunakan indera penglihatan untuk mendeteksi karakteristik normal atau tanda tertentu dari bagian tubuh atau fungsi tubuh pasien. Inspeksi digunakan untuk mendeteksi bentuk, warna, posisi, ukuran, tumor dan lainnya dari tubuh pasien.
 - b. Cara pemeriksaan Inspeksi
 - 1) Bagian tubuh yang diperiksa harus terbuka (diupayakan pasien membuka sendiri pakaiannya sebaiknya pakaian tidak dibuka sekaligus, namun dibuka seperlunya untuk pemeriksaan sedangkan bagian lain ditutupi selimut).
 - 2) Bandingkan bagian tubuh yang berlawanan (kesimetrisan) dan abnormalitas.
 - 3) Catat hasilnya.

C. Palpasi

Cara Pemeriksaan Palpasi: Lakukan palpasi secara hati-hati apabila diduga adanya fraktur tulang.

1. Hindari tekanan yang berlebihan pada pembuluh darah.
2. Lakukan palpasi ringan apabila memeriksa organ/jaringan yang dalamnya kurang dari 1 cm.
3. Lakukan palpasi agak dalam apabila memeriksa organ/jaringan dengan kedalaman 1-2,5 cm.
4. Lakukan palpasi bimanual apabila melakukan pemeriksaan dengan kedalaman lebih dari 2,5 cm. yaitu dengan mempergunakan kedua tangan dimana satu tangan direlaksasi dan diletakkan dibagian bawah organ/jaringan tubuh, sedangkan tangan yang lain menekan kearah tangan yang di bawah untuk mendeteksi karakteristik organ/jaringan.
5. Rasakan dengan seksama kelainan organ/jaringan, adanya nodul, tumor bergerak/tidak dengan konsistensi padat/kenyal, bersifat kasar/lembut, ukurannya dan ada/tidaknya getaran/trill, serta rasa nyeri raba/tekan.
6. Catatlah hasil pemeriksaan yang didapat.

D. Perkusi

Gelombang suara yaitu semakin banyak jaringan, semakin lemah hantarnya dan udara/gas paling resonan.

Cara Pemeriksaan Perkusi:

1. Posisi pasien dapat tidur, duduk atau berdiri tergantung pada bagian mana yang akan diperiksa dan bagian tubuh yang diperiksa harus terbuka.
2. Pastikan pasien dalam keadaan rileks dan posisi yang nyaman untuk menghindari ketegangan otot yang dapat mengganggu hasil perkusi.
3. Minta pasien untuk menarik napas dalam agar meningkatkan relaksasi otot.
4. Kuku jari-jari pemeriksa harus pendek, tangan hangat dan kering.
5. Lakukan perkusi secara seksama dan sistematis yaitu dengan:
6. Metode langsung yaitu melakukan perkusi atau mengetokan jari tangan langsung dengan menggunakan 1 atau 2 ujung jari.
7. Metode tidak langsung dengan cara sebagai berikut:
8. Jari tengah tangan kiri (yang tidak dominan) sebagai fleksimeter diletakkan dengan lembut di atas permukaan tubuh, upayakan telapak tangan dan jari-jari lain tidak menempel pada permukaan tubuh.
9. Ujung jari tengah dari tangan kanan (dominan) sebagai fleksor, untuk memukul/mengetuk persendian distal dari jari tangan tangan kiri.
10. Pukulan harus cepat, tajam dengan lengan tetap/tidak bergerak dan pergelangan tangan rileks.
11. Berikan tenaga pukulan yang sama pada setiap area tubuh.
12. Bandingkan bunyi frekuensi dengan akurat.
13. Bandingkan atau perhatikan bunyi yang dihasilkan oleh perkusi.
14. Bunyi timpani mempunyai intensitas keras, nada tinggi, waktu agak lama, dan kualitas seperti drum(lambung).
15. Bunyi resonan mempunyai intensitas menengah nada rendah, waktu lama, kualitas bergema (pannormal).
16. Bunyi hipersonar mempunyai intensitas amat keras, waktu lebih lama, kualitas ledakan (empisema paru).
17. Bunyi pekak mempunyai intensitas lembut sampai menengah, nada tinggi, waktu agak lama kualitas seperti petir (hati).

E. Definisi Auskultasi Dan Cara Pemeriksaan Auskultasi

Auskultasi yang dilakukan di dada untuk mendengar suara napas dan bila dilakukan di abdomen mendengarkan suara bising usus.

Penilaian pemeriksaan Auskultasi meliputi:

1. Frekuensi yaitu menghitung jumlah getaran permenit.
2. Durasi yang lama bunyi yang terdengar.
3. Intensitas bunyi yaitu ukuran yang kuat/lemahnya suara.
4. Kualitas yaitu warna nada/variasi suara.

Pemeriksaan harus mengenal berbagai tipe bunyi normal yang terdengar pada orang yang berbeda, sehingga bunyi abnormal dapat dideteksi dengan sempurna. Untuk mendeteksi suara diperlukan, mengumpulkan dan memilih frekuensi suara. Stetoskop terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian kepala, selang karet/plastik dan telinga. Selang karet/plastik stetoskop harus lentur dengan panjang 30–40 cm dan bagian telinga stetoskop yang mempunyai sudut binaural dan bagiannya ujungnya mengikuti lekuk dari rongga telinga kepala stetoskop pada waktu digunakan menempel pada kulit pasien.

Ada 2 jenis kepala stetoskop yaitu:

1. Bel stetoskop digunakan untuk bunyi bernada rendah pada tekanan ringan, seperti pada bunyi jantung dan vaskuler. Bila ditekan lebih kuat maka nada frekuensi tinggi terdengar lebih keras karena kulit menjadi teranggang, maka cara kerjanya seperti diafragma.
2. Diafragma digunakan untuk bunyi bernada tinggi seperti bunyi usus dan paru.

Cara Pemeriksaan Auskultasi:

1. Posisi pasien dapat tidur, duduk atau berdiri tergantung bagian yang mana yang diperiksa dan bagian tubuh yang diperiksa harus terbuka.
2. Pastikan pasien dalam keadaan rile dengan posisi yang nyaman.
3. Pastikan stetoskop sudah terpasang baik dan tidak bocor antara bagian kepala, selang dan telinga.
4. Pasanglah ujung stetoskop bagian telinga kelubang telinga pemeriksa sesuai arah, ukuran dan lengkungannya stetoskop telinga.
5. Hangatkan dulu kepala stetoskop dengan cara menempelkan pada telapak tangan pemeriksa atau menggosokkan pada pakaian pemeriksa.
6. Tempelkan kepala stetoskop pada bagian tubuh pasien yang akan diperiksa dan lakukan pemeriksaan dengan seksama dan sistematis.

7. Pergunakanlah bel stetoskop untuk mendengarkan bunyi bernada rendah pada tekanan ringan yaitu pada bunyi jantung dan vaskuler dan gunakan diafragma untuk bunyi bernada tinggi seperti bunyi usus dan paru.
8. Informasikan hasil pemeriksaan dan catat pada status.

F. Cara Pemeriksaan Inspeksi Abdomen

Inspeksi dilakukan pada pasien dengan posisi tidur terlentang dan diamati dengan seksama dinding abdomen. Yang perlu diperhatikan adalah

1. Keadaan kulit

- warnanya (ikterus, pucat, coklat kehitaman)
- Elastisitasnya (menurun pada orang tua dan dehidrasi)
- Kering/ dehidrasi, lembab (asites)
- Adanya bekas- bekas garukan (penyakit ginjal kronik, ikterus obstruktif)
- Jaringan parut (tentukan lokasinya)
- Striae (*gravidarum/cushing syndrome*)
- Pelebaran pembuluh darah vena (obstruksi vena kava inferior dan kolateral pada hipertensi portal).

2. Besar dan bentuk abdomen: rata, menonjol, atau scaphoid (cekung).

3. Simetrisitas: perhatikan adanya benjolan lokal (hernia, hepatomegali, splenomegali, kista ovarii, hidronefrosis).

4. Peristaltik: gerakan peristaltik usus meningkat pada obstruksi ileus, tampak pada dinding abdomen dan bentuk usus juga tampak (*darm-contour*).

5. Pulsasi aorta: dapat terlihat pada pasien yang sangat kurus, terutama bila terdapat obstruksi usus dan akan terlihat normal di area epigastrium. Pemeriksaan aneurisma aorta abdominal adalah prosedur untuk memeriksa pelebaran abnormal pada pembuluh darah besar di perut (*aorta abdominalis*). Pemeriksaan ini dianjurkan sejak awal aneurisma aorta abdominal terjadi, karena jika terlambat, aorta dapat melebar dan akhirnya pecah. Aneurisma aorta abdominal (AAA) adalah kondisi ketika aorta di perut melebar secara abnormal. Aorta merupakan pembuluh darah kaya oksigen (*arteri*) utama yang keluar dari jantung. Pembuluh ini berfungsi untuk menyuplai darah ke seluruh tubuh.

6. Perhatikan juga gerakan pasien: bila pasien sering merubah posisi mengindikasikan adanya obstruksi usus. Bila pasien sering menghindari gerakan menunjukkan adanya iritasi peritoneum generalisata. Bila pasien sering melipat lutut ke atas agar tegangan abdomen berkurang/relaksasi menunjukkan adanya peritonitis.

G. Latihan Soal

- Urutan pemeriksaan abdomen yang benar adalah...
 - Palpasi–perkusi–auskultasi–inspeksi
 - Inspeksi–auskultasi–perkusi–palpasi
 - Inspeksi–palpasi–perkusi–auskultasi
 - Auskultasi–palpasi–perkusi–inspeksi
- Auskultasi abdomen bertujuan menilai ...
 - Nyeri tekan
 - Bising usus
 - Massa abdomen
 - Ukuran organ
- Palpasi abdomen dalam dilakukan untuk menilai ...
 - Suhu kulit
 - Turgor
 - Massa dan organ dalam
 - Warna kulit
- Perkusi abdomen berguna untuk menilai ...
 - Densitas jaringan
 - Refleks
 - Nyeri
 - Peristaltik
- Suara timpani menunjukkan adanya ...
 - Jaringan padat
 - Cairan
 - Udara
 - Lemak
- Nyeri lepas tekan disebut ...
 - Nyeri viseral
 - Nyeri tekan
 - Rebound tenderness
 - Guarding
- Hati normal teraba ...
 - 5 cm di bawah arkus kosta
 - Tepat di umbilicus
 - Tidak teraba
 - Sedikit di bawah arkus kosta kanan
- Bising usus normal terdengar ...
 - 1–2 kali/menit
 - 5–30 kali/menit
 - 40–60 kali/menit
 - Tidak terdengar
- Distensi abdomen dapat disebabkan oleh ...
 - Gas
 - Cairan
 - Massa
 - Semua benar
- Palpasi harus dilakukan terakhir karena ...
 - Menyebabkan nyeri
 - Mengganggu bising usus
 - Membutuhkan waktu lama
 - Tidak penting

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN FISIK ABDOMEN	
Pengertian	Melakukan pemeriksaan/pengkajian fisik secara lengkap
Tujuan	1. Menegakkan diagnosa 2. Mengenali kelainan pada klien 3. Sebagai data dasar
Persiapan Alat/Bahan	1. <i>Handscoon</i> non steril 2. <i>Penlight</i> 3. Metlin 4. Stetoskop 5. Kasa 6. Bengkok 7. Buku catatan 8. Pena 9. Pengukur TB dan BB
Prosedur Tindakan	Tahap Persiapan: 1. Justifikasi identitas klien (nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis) 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan 3. Lakukan cuci tangan Komunikasi Terapeutik: 1. Perkenalkan diri 2. Jelaskan pada klien tujuan tindakan yang akan dilakukan 3. Jaga privasi klien dan atur lingkungan sekitar klien 4. Bantu klien untuk mengatur posisi senyaman mungkin Tahap Kerja Pemeriksaan Abdomen Inspeksi 1. Posisikan klien berbaring telentang 2. Perhatikan kulit dan warna abdomen, bentuk perut, jaringan parut, luka striae dan bayangan vena, kesimetrisan 3. Perhatikan posisi, bentuk, warna dan inflamasi dari umbilicus 4. Amati gerakan permukaan, massa, pembesaran atau penengangan abdomen 5. Inspeksi abdomen untuk gerakan pernafasan normal Auskultasi 1. Letakkan sisi diafragma stetoskop yang telah dihangatkan pada sisi kuadran kiri bawah 2. Minta klien untuk tidak bicara dan beri tekanan ringan 3. Dengarkan bising usus selama 5 menit (bila mungkin) 4. Bila bising usus tidak terdengar, lanjutkan pemeriksaan dengan sistematis dan dengarkan tiap kuadran abdomen

5. Gunakan sisi bel stetoskop dan dengarkan bunyi desiran di bagian epigastrik dan pada tiap kuadran abdomen

Perkusi

Perkusi Batas Hati

1. Lakukan perkusi pada garis midklavikula kanan setinggi umbilikus, geser perlahan ke atas samapi terjadi perubahan suara dari timpani menjadi pekak dan tandai batas hati tersebut
2. Untuk mengetahui batas atas, mulai perkusi ke arah bawah di garis mid klavikula kanan pada area resonansi paru. Kemudian perhatikan perubahan bunyi dari resonan ke pekak
3. Ukur jarak antara batas atas dan bawah

Perkusi Lambung

1. Lakukan perkusi pada tulang iga bagian bawah dan bagian epigastrium kiri
2. Deskripsikan bunyi yang didapatkan

Perkusi Ginjal

1. Posisikan klien duduk dan pemeriksa dibelakang klien
2. Perkusi sudut costovertebral digaris skapular sisi ulnar tangan kanan
3. Tanyakan pada klien n rasa nyeri yang timbul (normal tidak nyeri)

Palpasi

1. Posisi klien berbaring kembali
2. Tempatkan tangan di atas abdomen secara datar, jari-jari ekstensi dan berhimpitan
3. Palpasi dengan hati-hati sedalam 1 cm untuk mendeteksi area nyeri, penegangan abdomen dan massa, lanjutkan palpasi dalam (2,5-7,5cm)
4. Palpasi dilakukan di tiap kuadran abdomen
5. Perhatikan perubahan wajah klien selama palpasi

Palpasi Hati dan Kandung Empedu

1. Letakkan tangan kiri dibawah torak/dada kanan posterior klien pada iga ke-11 dan ke-12 kemudian tekan ke arah atas
2. Letakkan telapak tangan kanan diatas abdomen, jari-jari mengarah ke kepala dan ekstensika sehingga ujung-ujung jari terletak digaris klavikula dibawah hati
3. Tekan dengan lembut ke dalam dan ke atas
4. Minta klien menarik nafa dalam dan raba tepi abdomen saat abdomen mengempis
5. Palpasi tepi bawah hati pada sisi lateral dari otot rektus
6. Bila diduga ada penyakit kandung kemih, minta klien untuk menarik nafas dalam selama palpasi

	Palpasi Limpa 1. Letakkan secara menyilang telapak tangan kiri pemeriksa di bawah pinggang kiri klien dan tekan ke atas 2. Letakkan telapak tangan kanan dengan jari-jari ekstensi di atas abdomen di bawah tepi kiri kosta Tahap Terminasi 1. Lakukan cuci tangan 2. Lakukan evaluasi terhadap klien tentang kegiatan yang telah dilakukan Dokumentasi 1. Catat hasil tindakan yang telah dilakukan 2. Catat respon klien 3. Sampaikan hasil pemeriksaan pada klien 4. Lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya
--	--

BAB 5

Pemeriksaan Muskuloskeletal

A. Pengertian Sistem Muskuloskeletal

Sistem muskuloskeletal merupakan sistem tubuh yang mencakup otot, tulang, serta jaringan ikat seperti tendon dan ligamen. Sistem ini berperan dalam menopang dan melindungi organ tubuh serta memungkinkan terjadinya pergerakan. Gangguan pada sistem muskuloskeletal dapat berupa nyeri punggung, artritis, cedera otot, dan berbagai keluhan lain yang dapat mengganggu kemampuan gerak dan fungsi individu.

Pemeriksaan muskuloskeletal adalah penilaian komprehensif terhadap otot, tulang, dan jaringan ikat untuk mengidentifikasi kelainan struktural maupun fungsional. Pemeriksaan dilakukan menggunakan prosedur dan uji standar, yang meliputi inspeksi sendi, palpasi, penilaian rentang gerak, evaluasi kekuatan otot, serta manuver khusus yang memberikan tekanan pada sendi.

B. Jenis dan Fungsi Sistem Muskuloskeletal

Adapun struktur dan fungsi dari sistem muskuloskeletal, diantaranya:

1. Tulang

Tulang dalam sistem muskuloskeletal memiliki fungsi yang sangat berperan dalam bentuk struktur tubuh dan pergerakan yang dimana, tulang memiliki jenisnya sendiri, diantaranya:

a. Tulang Panjang

Yang dimana tulang ini memerankan fungsi menopang berat tubuh seperti halnya tulang femur atau tulang paha.



Gambar 5.1 Tulang Femur

b. Tulang Pendek

Merupakan tulang kecil yang menyediakan stabilitas dan memungkinkan gerakan halus serta fleksibilitas seperti tulang karpal atau pergelangan tangan.



Gambar 5.2 Tulang Pergelangan Tangan (karpal)

c. Tulang Pipih

Merupakan tulang yang melindungi organ-organ dalam tubuh dan menyediakan area untuk perlekatan seperti Tulang rusuk melindungi paru-paru dan jantung.



Gambar 5.3 Tulang Rusuk

d. Tulang Tidak Beraturan

Yakni tulang yang memiliki fungsi melindungi struktur penting seperti sumsum tulang belakang dan mendukung struktur wajah seperti tulang belakang atau vertebra.



Gambar 5.4 Tulang Belakang

e. Tulang Sesmoid

Yakni tulang yang memiliki fungsi utamanya adalah untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan efisiensi pergerakan tendon seperti pataka atau tempurung lutut yang ada di lutut kaki yang membantu pergerakan tendon quadriceps saat lutut ditekuk dan diluruskan.

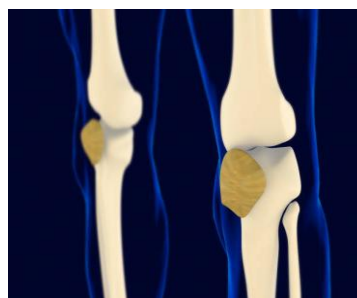


Gambar 5.5 Tulang Sesmoid (Patela) pada Regio Paha dan Lutut

2. Otot

Merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal yang memungkinkan tubuh untuk bergerak dan berfungsi dengan baik. Adapun pembagian jenis-jenis dari otot, diantaranya:

a. Otot Rangka



Gambar 5.6 Otot Rangka

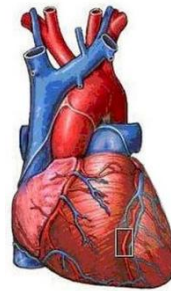
Merupakan otot yang bertanggung jawab atas gerakan yang bisa kita kendalikan secara sadar, seperti berjalan, mengangkat benda, dan berbicara yang punya struktur berbentuk serat panjang dan memiliki garis-garis melintang yang dimana otot ini melekat pada tulang melalui tendon, contohnya seperti: otot biceps, triceps, deltoit.



Gambar 5.6 Otot Biceps

b. Otot Jantung

Otot jantung berperan dalam memompa darah ke seluruh tubuh dan bekerja secara involunter. Secara struktur, otot ini memiliki garis melintang menyerupai otot rangka, namun serabutnya bercabang dan saling berhubungan melalui diskus interkalar.



Gambar 5.7 Jantung

c. Otot Polos

Otot polos berfungsi mengatur gerakan involunter dalam tubuh, seperti kontraksi saluran pencernaan dan aliran darah dalam pembuluh. Otot ini tidak memiliki garis melintang, berbentuk sel spindel, dan umumnya terdapat pada dinding organ-organ dalam.

3. Sendi

Merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal yang berfungsi sebagai mobilitas tulang dapat bergerak ke arah tertentu. adapun klasifikasi sendi berdasarkan beberapa hal, diantaranya:

a. Berdasarkan Struktur

- 1) Sendi Fibrosa: merupakan sendi yang tulang-tulanganya disatukan oleh jaringan fibrosa seperti sutura pada tengkorak.

- 2) Sendi Kartilaginosa: yakni Tulang-tulang yang dihubungkan oleh kartilago seperti sendi antara tulang rusuk dan sternum
 - 3) Sendi Sinovial: yakni sendi yang paling umum pada manusia yang memungkinkan gerakan yang luas yang dimana memiliki kapsul sendi yang berisi cairan sinovial seperti sendi lutut, sendi bahu.
- b. Berdasarkan Fungsi
- 1) Sendi Sinartrosis: yakni sendi yang tidak memungkinkan pergerakan seperti sutura pada tengkorak.
 - 2) Sendi Amfiartrosis: Sendi yang memungkinkan pergerakan terbatas. seperti sendi antara tulang belakang.
 - 3) Sendi Diartrosis: Sendi yang memungkinkan pergerakan tulang kita bebas seperti sendi lutut, sendi bahu.
- c. Jenis-Jenis Sendi Sinovial
- 1) Sendi Engsel: Memungkinkan gerakan satu arah seperti engsel pintu seperti sendi lutut, sendi siku.
 - 2) Sendi Pelana: Memungkinkan gerakan lebih luas dalam dua arah seperti halnya sendi antara tulang karpal (pergelangan tangan) dan metakarpal pada ibu jari.
 - 3) Sendi Peluru: Memungkinkan gerakan rotasi dan berbagai arah seperti sendi bahu, sendi panggul.
 - 4) Sendi Putar: Memungkinkan gerakan rotasi seperti sendi antara tulang atlas (tulang belakang awal servik(leher) dan aksis pada leher.
 - 5) Sendi Geser: Memungkinkan gerakan meluncur seperti sendi antara tulang karpal; dan
 - 6) Sendi Elipsoid: Memungkinkan gerakan dalam dua arah, contohnya seperti sendi antara tulang radius dan karpal.

C. Pemeriksaan Muskuloskeletal

Berikut merupakan langkah-langkah yang umum dilakukan dalam pemeriksaan sistem muskuloskeletal:

1. Anamnesis (Riwayat Medis)
 - a. Tanyakan tentang keluhan utama pasien/klien, riwayat penyakit sebelumnya, cedera, dan aktivitas fisik.
 - b. Tanyakan tentang gejala seperti nyeri, kekakuan, pembengkakan, atau kelemahan.
2. Inspeksi (Pengamatan)
 - a. Amati postur tubuh, cara berjalan (gait), dan simetri tubuh.
 - b. Perhatikan adanya deformitas, pembengkakan, atau perubahan warna kulit.

- c. Perhatikan aktivitas otot dan adanya ketidakseimbangan.
- 3. Palpasi (Perabaan)
 - a. Rabalah area yang diperiksa untuk mendeteksi nyeri tekan, pembengkakan, krepitasi (bunyi gesekan), dan perubahan suhu kulit.
 - b. Periksa otot, tulang, dan sendi untuk mengetahui adanya kelainan atau kekakuan.
- 4. Pemeriksaan Rentang Gerak (Range of Motion)
 - a. Gerakan Aktif: Minta pasien untuk menggerakkan sendi secara mandiri dan amati rentang gerak serta rasa nyeri.
 - b. Gerakan Pasif: Pemeriksa membantu menggerakkan sendi pasien untuk menilai rentang gerak tanpa usaha pasien.
- 5. Pemeriksaan Kekuatan Otot
 - a. Minta pasien untuk melawan tekanan yang diberikan oleh pemeriksa pada berbagai kelompok otot.
 - b. Gunakan skala 0–5 untuk menilai kekuatan otot, di mana 0 berarti tidak ada kontraksi otot dan 5 berarti kekuatan otot normal.
- 6. Pemeriksaan Fungsi Sendi
 - a. Lakukan tes khusus untuk menilai fungsi sendi, seperti tes McMurray untuk meniskus, tes Lachman untuk ligamen anterior cruciatum (ACL), dan tes lainnya sesuai dengan keluhan pasien.
 - b. Periksa stabilitas sendi dengan menggerakkan sendi ke arah yang berbeda.
- 7. Pemeriksaan Neurologis
 - a. Periksa refleks tendon dalam, seperti refleks patela dan Achilles.
 - b. Tanyakan tentang adanya sensasi abnormal atau mati rasa.
 - c. Periksa kekuatan otot dan koordinasi gerakan.
- 8. Pemeriksaan Vaskular
 - a. Periksa nadi perifer untuk menilai aliran darah.
 - b. Periksa warna kulit dan waktu pengisian kapiler (capillary refill time) untuk menilai sirkulasi darah.

D. Latihan Soal

1. Sistem muskuloskeletal berfungsi utama untuk ...
A. Produksi hormon
B. Proteksi imun
C. Pergerakan dan postur
D. Regulasi suhu
2. Pemeriksaan muskuloskeletal menilai ...
A. Warna kulit
B. Range of Motion
C. Refleks pupil
D. Tekanan darah
3. Pemeriksaan ROM aktif berarti ...
A. Digunakan alat
B. Digerakkan pemeriksa
C. Digunakan anestesi
D. Dilakukan pasien sendiri
4. Nyeri saat pergerakan menunjukkan kemungkinan ...
A. Inflamasi
B. Anemia
C. Hipoksia
D. Edema
5. Krepitasi biasanya ditemukan pada ...
A. Fraktur
B. Arthritis
C. Dislokasi
D. Semua benar
6. Deformitas sendi menandakan ...
A. Kelainan struktural
B. Gangguan neurologis
C. Infeksi sistemik
D. Gangguan kardiak
7. Kekuatan otot dinilai dengan skala ...
A. 0–3
B. 0–4
C. 0–5
D. 1–10
8. Postur normal ditandai oleh ...
A. Skoliosis
B. Lordosis berlebihan
C. Keseimbangan simetris
D. Kifosis berat
9. Pemeriksaan muskuloskeletal dilakukan secara ...
A. Acak
B. Sistematis
C. Sebagian
D. Opsional
10. Tujuan utama pemeriksaan adalah ...
A. Diagnosis medis
B. Menentukan terapi obat
C. Menilai fungsi dan mobilitas
D. Menentukan prognosis penyakit

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN FISIK MUSKULOSKELETAL	
Pengertian	Melakukan pemeriksaan/pengkajian fisik secara lengkap
Tujuan	1. Menegakkan diagnosa 2. Mengenali kelainan pada klien 3. Sebagai data dasar
Persiapan Alat/Bahan	1. <i>Handscoon</i> non steril 2. <i>Penlight</i> 3. Metlin 4. Kasa 5. Bengkok 6. Buku catatan 7. Pena
Prosedur Tindakan	Tahap Persiapan: 1. Justifikasi identitas klien (nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis) 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan 3. Lakukan cuci tangan Komunikasi Terapeutik: 1. Perkenalkan diri 2. Jelaskan pada klien tujuan tindakan yang akan dilakukan 3. Jaga privasi klien dan atur lingkungan sekitar klien 4. Bantu klien untuk mengatur posisi senyaman mungkin Tahap Kerja Pemeriksaan Muskuloskeletal Inspeksi Perhatikan: 1. Penilaian meliputi penampilan umum, pola berjalan, postur tubuh, cara bergerak, serta kesimetrisan tubuh dan ekstremitas (dengan membandingkan sisi kanan dan kiri pada ekstremitas atas maupun bawah). Selain itu, diperhatikan pula adanya rasa tidak nyaman, pincang, atau nyeri yang muncul saat berjalan. 2. Kelumpuhan badan dan atau anggota gerak. Adanya fraktur atau tidak 3. Warna kulit pada ekstremitas (kemerahan / kebiruan / hiperpigmentasi) 4. Periksa adanya benjolan / pembengkakan pada ekstremitas. Adanya atrofi / hipertrofi otot, struktur tulang dan otot. Amati otot kemungkinan adanya kontraksi abnormal dan tremor

Palpasi

1. Palpasi pada setiap ekstremitas dan rasakan :
 5. Kekuatan / kualitas nadi perifer
 6. Adanya nyeri tekan atau tidak
 7. Adanya krepitasi atau tidak
 8. Konsistensi otot (lembek / keras)

Kaji ROM (Range of Motion)

1. Pasien diminta untuk menarik atau mendorong tangan pemeriksa guna membandingkan kekuatan otot ekstremitas kanan dan kiri. Penilaian kekuatan otot juga dapat dilakukan dengan meminta pasien menggerakkan anggota tubuh dalam berbagai posisi, seperti menggerakkan kepala atau lengan. Pada kondisi normal, pasien mampu menggerakkan anggota tubuh secara horizontal melawan gaya gravitasi.
2. Amati kekuatan suatu bagian tubuh dengan cara memberi tahanan secara resisten. Secara normal kekuatan otot dinilai dalam 5 tingkatan gradasi

Skala	Normal Kekuatan (%)	Ciri
0	0	Paralisis total
1	10	Tidak ada gerakan, teraba/terlihat adanya kontraksi otot
2	25	Gerakan otot penuh menentang gravitasi, dengan sokongan
3	50	Gerakan normal menentang gravitasi
4	75	Gerakan normal menentang gravitasi dengan sedikit tahanan
5	100	Gerakan normal penuh menentang gravitasi dengan tahanan penuh

Tahap Terminasi

1. Lakukan cuci tangan
2. Lakukan evaluasi terhadap klien tentang kegiatan yang telah dilakukan

Dokumentasi

1. Catat hasil tindakan yang telah dilakukan
2. Catat respon klien
3. Sampaikan hasil pemeriksaan pada klien
4. Lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya

BAB 6

Pemeriksaan Neurologis

A. Pengertian Pemeriksaan Neurologis

Pemeriksaan neurologis merupakan proses penilaian yang memerlukan ketelitian dan pengalaman, serta mencakup berbagai pemeriksaan terhadap fungsi neurologis yang spesifik. Meskipun sering dilakukan secara sederhana, pemeriksaan ini memiliki peran penting dalam menilai kondisi pasien secara menyeluruh dengan mempertimbangkan riwayat penyakit dan kondisi fisik lainnya.



Gambar 6.1 Inspeksi Kepala dan Leher pada Pemeriksaan Neurologis

Banyak fungsi neurologis dapat dinilai selama pengkajian riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik rutin, antara lain pola bicara, status mental, gaya berjalan, postur tubuh, kekuatan motorik, dan koordinasi. Aktivitas sederhana, seperti berjabat tangan dengan pasien, juga dapat memberikan informasi awal mengenai fungsi neurologis.

Dalam menilai tingkat kesadaran, perlu dibedakan antara kondisi tidur dan penurunan kesadaran. Pasien yang tidur masih dapat dibangunkan dengan

rangsangan ringan atau sedang, sedangkan pasien koma tidak menunjukkan respons terhadap berbagai rangsangan. Pada pasien dengan gangguan kesadaran, terutama dalam kondisi gawat darurat, pemeriksaan cepat dapat dilakukan menggunakan metode AVPU, yaitu *Alert*, *Respond to Voice*, *Respond to Pain*, dan *Unresponsive*.

Berikut merupakan tabel AVPU:

Tabel 6.1 Pemeriksaan AVPU

Pemeriksaan AVPU		
A	<i>Alert</i> (sadar)	Klien sadar penuh, membuka mata spontan, dapat menggerakkan kaki/tangan sebagaimana diperintahkan, dan menjawab pertanyaan sederhana secara benar.
V	<i>Respond to Voice</i> (berespon terhadap suara)	Klien hanya memberikan reaksi ketika di rangsang dengan suara, klien mungkin hanya bereaksi dengan suara-suara yang tidak berarti, mengerang, atau hanya membuka mata.
P	<i>Respond to Pain</i> (berespon terhadap nyeri)	Klien hanya memberikan reaksi ketika dirangsang dengan sensasi nyeri (contoh pijatan di kuku jari), klien hanya bereaksi dengan menarik, fleksi, atau bahkan ekstensi.
U	<i>Unresponsive</i> (tidak ada respon)	Klien tidak menunjukkan reaksi sama sekali

Untuk penilaian yang lebih rinci dan akurat, digunakan Glasgow Coma Scale (GCS). Pemeriksaan ini sangat penting dalam evaluasi status neurologis, terutama pada kasus trauma seperti cedera kepala, karena berfungsi menentukan tingkat keparahan cedera otak. Penilaian GCS dilakukan dengan memberikan rangsangan suara dan nyeri, kemudian mengevaluasi respons pasien yang meliputi pembukaan mata, respons motorik, dan respons verbal. Hasil pemeriksaan tingkat kesadaran menggunakan GCS disajikan dalam tabel penilaian.

Tabel 6.2 Tabel Penilaian GCS

Parameter	Respons	Nilai
Membuka Mata	Spontan	4
	Berespons terhadap suara	3
	Berespons terhadap nyeri	2
	Tidak ada respons	1
Respons Verbal	Orientasi baik	5
	Binggung	4
	Kata-kata tidak jelas	3
	Mengerang	2
	Tidak ada respons suara	1

Respons Motorik (Pergerakan Motorik)	Mengikuti perintah	6
	Lokalisasi terhadap nyeri	5
	Fleksi,Menarik	4
	Fleksi abnormal	3
	Ekstensi abnormal	2
	Tidak ada	1

Nilai maksimal penilaian dengan menggunakan GCS adalah 15 sementara nilai minimal adalah 3. Nilai kurang atau sama dengan 8 menunjukkan klien dengan kesadaran koma; skor 9-12: gangguan kesadaran tingkat sedang; dengan skor 13-15: gangguan kesadaran tingkat ringan (kesadaran baik). Berdasarkan pengkajian kesadaran maka dapat di buat kesimpulan mengenai tingkat kesadaran klien yang di nyatakan dengan sadar penuh (Composmentis), Letargi, Stupor, Semikoma atau koma.

B. Prosedur Pemeriksaan Fisik Nervus Cranialis

Saraf kranial merupakan bagian dari sistem saraf perifer. Sistem ini terdiri atas saraf kranial yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari medula spinalis. Terdapat dua belas pasang saraf kranial yang diberi penomoran dengan angka Romawi dan keluar dari berbagai bagian batang otak. Saraf kranial tersusun atas serabut saraf sensorik, motorik, atau kombinasi keduanya.

Pemeriksaan saraf merupakan salah satu dari rangkaian pemeriksaan neurologis yang terdiri dari:

1. Status mental
2. Tingkat kesadaran
3. Fungsi saraf kranial
4. Fungsi motorik
5. Refleks
6. Koordinasi dan gaya berjalan dan
7. Fungsi sensorik

Keberhasilan pemeriksaan saraf kranial sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara pemeriksa dan pasien. Selama pemeriksaan, pasien sering diminta melakukan tindakan tertentu yang mungkin terasa tidak biasa. Oleh karena itu, sebelum pemeriksaan dimulai, kecemasan pasien perlu diminimalkan dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, durasi, prosedur pemeriksaan, serta kemungkinan timbulnya rasa tidak nyaman. Penjelasan yang jelas akan membantu membangun kepercayaan

pasien dan meningkatkan kepatuhan dalam mengikuti instruksi serta menjawab pertanyaan dengan tepat.

Anamnesis yang komprehensif dan teliti, disertai pemeriksaan fisik yang adekuat, mampu menegakkan diagnosis pada sebagian besar kasus. Meskipun tersedia berbagai metode diagnostik modern, anamnesis dan pemeriksaan fisik tetap menjadi komponen utama yang tidak dapat digantikan.

Saraf kranial berasal langsung dari otak dan keluar melalui lubang pada tulang tengkorak yang disebut foramina. Terdapat dua belas pasang saraf kranial yang diberi penamaan dan penomoran dengan angka Romawi, yaitu olfaktorius (I), optikus (II), okulomotorius (III), troklearis (IV), trigeminus (V), abduzens (VI), fasialis (VII), vestibulokoklearis (VIII), glossofaringeus (IX), vagus (X), aksesorius (XI), dan hipoglosus (XII).

Saraf kranial I, II, dan VIII merupakan saraf sensorik; saraf kranial III, IV, XI, dan XII berfungsi sebagai saraf motorik serta mengandung serabut propioseptif. Saraf kranial V, VII, dan X termasuk saraf campuran. Selain itu, saraf kranial III, VII, dan X juga membawa serabut parasimpatis sebagai bagian dari sistem saraf otonom.

1. Nervus Olfaktori (N. I):
 - a. Fungsi: saraf sensorik, untuk penciuman
 - b. Cara Pemeriksaan, pasien memejamkan mata, pasien disuruh membedakan bau yang dirasakan (kopi, teh, dll)
2. Nervus Optikus (N. II)
 - a. Fungsi: saraf sensorik, untuk penglihatan
 - b. Cara Pemeriksaan: Dengan snellend card, dan periksa lapang pandang
3. Nervus Okulomotoris (N. III)
 - a. Fungsi: saraf motorik, untuk mengangkat kelopak mata keatas, kontriksi pupil, dan sebagian gerakan ekstraokuler
 - b. Cara Pemeriksaan: Tes putaran bola mata, menggerakkan konjungtiva, refleks pupil dan inspeksi kelopak mata
4. Nervus Trochlearis (N. IV)
 - a. Fungsi: saraf motorik, gerakan mata kebawah dan kedalam
 - b. Cara Pemeriksaan: Sama seperti nervus III
5. Nervus Trigemini (N. V)
 - a. Fungsi: saraf motorik, gerakan mengunyah, sensasi wajah, lidah dan gigi, refleks kornea dan refleks kedip.
 - b. Cara Pemeriksaan: menggerakkan rahang kesemua sisi, pasien

memejamkan mata, sentuh dengan kapas pada dahi atau pipi.
menyentuh permukaan kornea dengan kapas.

6. Nervus Abdusen (N. VI)
 - a. Fungsi: saraf motorik, deviasi mata ke lateral
 - b. Cara pemeriksaan: sama seperti nervus III
7. Nervus Fasialis (N. VII)
 - a. Fungsi: saraf motorik, untuk ekspresi wajah
 - b. Cara pemeriksaan: senyum, bersiul, mengangkat alis mata, menutup kelopak mata dengan tahanan, menjulurkan lida untuk membedakan gula dan garam
8. Nervus Vestibulocochlearis (N. VIII)
 - a. Fungsi: saraf sensorik, untuk pendengaran dan keseimbangan
 - b. Cara pemeriksaan: test webber dan rinne
9. Nervus Glossofaringeus (N. IX)
 - a. Fungsi: saraf sensorik dan motorik, untuk sensasi rasa
 - b. Cara pemeriksaan: membedakan rasa manis dan asam
10. Nervus Vagus (N. X)
 - a. Fungsi: saraf sensorik dan motorik, refleks muntah dan menelan
 - b. Cara pemeriksaan: menyentuh faring posterior, pasien menelan saliva, disuruh mengucap ah...
11. Nervus Asesoris (N. XI)
 - a. Fungsi: saraf motorik, untuk menggerakkan bahu
 - b. Cara pemeriksaan: suruh pasien untuk menggerakkan bahu dan lakukan tahanan sambil pasien melawan tahanan tersebut.
12. Nervus Hipoglossus
 - a. Fungsi: saraf motorik, untuk gerakan lidah
 - b. Cara pemeriksaan: pasien disuruh menjulurkan lidah dan menggerakkan dari sisi ke sisi.

C. Pemeriksaan Neurologis Refleks Fisiologis

Pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai fungsi sensorimotor tubuh. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan palu refleks.

Tujuan pemeriksaan:

1. Mengevaluasi fungsi sensorimotor tubuh
2. Menilai adanya lesi pada upper motor neuron (UMN) atau lower motor neuron (LMN)
3. Mendiagnosis berbagai kondisi neurologis, seperti stroke, cedera otak traumatik, multiple sclerosis, dan tumor otak

Cara pemeriksaan:

1. Periksa memastikan letak anatomis tendon yang akan diperiksa
2. Periksa mengayunkan palu refleks secara rileks ke arah tendon
3. Periksa mengamati gerakan yang disebabkan oleh palu refleks
4. Interpretasi hasil Hiperrefleks menandakan adanya lesi pada UMN, Hiporefleks menandakan adanya lesi pada LMN.

Contoh refleks fisiologis:

Refleks moncong, Refleks mencari akar, Refleks menggenggam, Refleks palmomental, Tanda Hoffmann, Tanda Tromner, Tanda glabellar.

D. Pemeriksaan Neurologis Tingkat Kesadaran

Pemeriksaan ini untuk menilai aktivitas otak dan kewaspadaan seseorang. Pemeriksaan ini penting untuk menegaskan diagnosis dan menentukan prognosis pasien. Salah satu metode pemeriksaan tingkat kesadaran yang sering digunakan adalah Glasgow Coma Scale (GCS). GCS adalah skala 15 poin yang menilai respons pasien terhadap stimulus membuka mata, berbicara, dan bergerak.

Cara menilai tingkat kesadaran dengan GCS:

1. Menilai respons membuka mata
2. Menilai respons verbal
3. Menilai respons motorik
4. Arti skor GCS
5. Skor 15 berarti pasien sepenuhnya sadar
6. Skor 8 atau lebih rendah umumnya menunjukkan koma
7. Skor 13 hingga 15 menunjukkan cedera otak traumatis ringan (gegar otak)
8. Skor 9 hingga 12 menunjukkan cedera otak sedang
9. Skor 3 hingga 8 menunjukkan cedera otak berat Keterbatasan GCS
GCS memiliki keterbatasan karena pasien yang terintubasi tidak dapat dinilai komponen verbal. Untuk mengatasi keterbatasan ini, dikembangkanlah FOUR Score yang lebih sederhana dan memberikan informasi yang lengkap.

E. Pemeriksaan Neurologis Nervus Kranialis

Pemeriksaan saraf kranial yang dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada otak atau batang otak. Pemeriksaan ini dapat membantu mendiagnosis berbagai kondisi, seperti stroke, cedera otak, dan tumor intrakranial.

1. Prosedur pemeriksaan
2. Pemeriksaan dilakukan pada pasien yang sadar
3. Pemeriksaan meliputi beberapa jenis uji yang spesifik untuk masing-masing nervus kranialis
4. Pemeriksaan dapat dilakukan secara simultan untuk beberapa nervus kranialis yang fungsinya berhubungan
5. Pemeriksaan dapat dikombinasikan dengan pemeriksaan neurologis lainnya
6. Pemeriksaan penunjang berupa CT scan atau MRI juga bisa dilakukan
7. Beberapa pemeriksaan nervus kranialis
8. Pemeriksaan lapang pandang
9. Pemeriksaan pengecapan
10. Pemeriksaan penciuman
11. Pemeriksaan penglihatan
12. Pemeriksaan gerakan mata
13. Pemeriksaan wajah
14. Pemeriksaan pendengaran dan keseimbangan
15. Pemeriksaan tonus otot
16. Kontraindikasi pemeriksaan
17. Pemeriksaan refleks oculocephalic, fungsi vestibulo-okular, dan fungsi nervus XI dikontraindikasikan untuk pasien cedera servikal.

F. Latihan Soal

1. Pemeriksaan neurologis bertujuan menilai ...
 - A. Sistem pencernaan
 - B. Sistem saraf
 - C. Sistem endokrin
 - D. Sistem respirasi
2. Saraf kranial berjumlah ...
 - A. 10 pasang
 - B. 11 pasang
 - C. 12 pasang
 - D. 13 pasang
3. Refleks fisiologis normal menunjukkan ...
 - A. Kerusakan saraf
 - B. Fungsi neurologis baik
 - C. Infeksi sistemik
 - D. Hipoksia
4. Tingkat kesadaran dinilai menggunakan ...
 - A. Skala nyeri
 - B. Glasgow Coma Scale
 - C. Barthel Index
 - D. APGAR
5. Nervus optikus berfungsi untuk ...
 - A. Pendengaran
 - B. Penciuman
 - C. Penglihatan
 - D. Bicara
6. Nervus vagus berperan dalam ...
 - A. Gerak mata
 - B. Fungsi otonom
 - C. Ekspresi wajah
 - D. Penciuman
7. Penurunan refleks menunjukkan ...
 - A. Hiperefleksia
 - B. Normorefleksia
 - C. Hiporefleksia
 - D. Hipertermia
8. Refleks patologis menandakan ...
 - A. Normal
 - B. Gangguan SSP
 - C. Gangguan perifer
 - D. Dehidrasi
9. Pemeriksaan neurologis harus dilakukan ...
 - A. Cepat
 - B. Kasar
 - C. Sistematis
 - D. Terbatas
10. Tujuan utama pemeriksaan neurologis adalah ...
 - A. Terapi
 - B. Pencegahan
 - C. Identifikasi gangguan
 - D. Rehabilitasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN FISIK NEUROLOGIS	
Pengertian	Melakukan pemeriksaan/pengkajian fisik secara lengkap
Tujuan	1. Menegakkan diagnosa 2. Mengenali kelainan pada klien 3. Sebagai data dasar
Persiapan Alat/Bahan	1. <i>Handscoon</i> non steril 2. <i>Penlight</i> 3. Metlin 4. Kasa 5. Bengkok 6. Buku catatan 7. Pena
Prosedur Tindakan	Tahap Persiapan: 1. Justifikasi identitas klien (nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis) 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan 3. Lakukan cuci tangan Komunikasi Terapeutik: 1. Perkenalkan diri 2. Jelaskan pada klien tujuan tindakan yang akan dilakukan 3. Jaga privasi klien dan atur lingkungan sekitar klien 4. Bantu klien untuk mengatur posisi senyaman mungkin Tahap Kerja Pemeriksaan Neurologis Secara Kualitatif 1. Compos mentis (<i>conscious</i>) adalah kondisi kesadaran normal, di mana pasien sadar sepenuhnya dan mampu menjawab seluruh pertanyaan terkait lingkungan sekitarnya. 2. Apatitis merupakan keadaan kesadaran dengan penurunan minat berinteraksi dengan lingkungan, ditandai sikap acuh dan kurang responsif. 3. Delirium adalah kondisi kesadaran yang terganggu, ditandai kegelisahan, disorientasi terhadap orang, tempat, dan waktu, perilaku agresif atau memberontak, berteriak, serta adanya halusinasi atau waham. 4. Somnolen (obtundasi/letargi) adalah penurunan tingkat kesadaran dengan respons psikomotor yang lambat; pasien mudah tertidur namun masih dapat dibangunkan dengan rangsangan dan mampu memberikan respons verbal, meskipun kemudian kembali tertidur. 5. Stupor (soporokoma) merupakan keadaan menyerupai tidur sangat dalam, di mana pasien hanya menunjukkan respons

terhadap rangsangan nyeri.

6. Coma (comatose), yaitu tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun (tidak ada respon kornea maupun reflek muntah, mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya)

Secara Kuantitatif

Penilaian dengan GCS (Glasgow Coma Scale)

1. Menilai Respon Membuka Mata (E)

- a. (4) : spontan
- b. (3) : dengan rangsang suara (suruh pasien membuka mata)
- c. (2) : dengan rangsang nyeri (misalnya menekan kuku jari)
- d. (1) : tidak ada respon

2. Menilai Respon Verbal (V)

- a. (5) : orientasi baik
- b. (4) : bingung, berbicara mengacau (sering bertanya berulang-ulang), disorientasi (orang, tempat, dan waktu)
- c. (3) : kata-kata saja (berbicara tidak jelas, tapi kata-kata masih jelas, namun tidak dalam satu kalimat)
- d. (2) : suara tanpa arti (mengerang)
- e. (1) : tidak ada respon

3. Menilai Respon Motorik (M)

- a. (6) : mengikuti perintah
- b. (5) : melokalisir nyeri (menjangkau & menjauhkan stimulus saat diberi rangsang nyeri)
- c. (4) : withdraws (menghindar / menarik extremitas atau tubuh menjauhi stimulus saat diberi rangsang nyeri)
- d. (3) : flexi abnormal (tangan satu atau keduanya posisi kaku diatas dada & kaki ekstensi saat diberi rangsang nyeri)
- e. (2) : ekstensi abnormal (tangan satu atau keduanya ekstensi di sisi tubuh, dengan jari mengepal & kaki ekstensi saat diberi rangsang nyeri)
- f. (1) : tidak ada respon

Pemeriksaan Nervus Kranialis

1. I Olfaktorius

Minta pasien untuk mengidentifikasi aroma non iritatif seperti kopi dengan mata tertutup

2. II Opticus

Minta klien membaca bagan Snellen

3. III Oculomotorius

Kaji delapan pergerakan mata dan reaksi serta akomodasi pupil terhadap cahaya

4. IV Troclearis

Kaji delapan pergerakan mata

5. V Trigeminus

	a. Sentuhkan kapas secara perlahan pada kornea untuk menguji reflex kornea b. Minta klien menutup mata, kemudian sentuhkan kapas, jarum, dan klip kertas secara bergantian pada kulit wajah klien c. Kaji kemampuan klien mengatupkan gigi 6. VI Abdusens Kaji arah tatapan klien 7. VII Facialis a. Minta klien untuk tersenyum, mengembungkan pipi, menaikkan dan menurunkan alis mata, kemudian perhatikan kesimetrisannya b. Minta klien untuk mengidentifikasi rasa manis dan asin di bagian depan dan pinggir lidah 8. VIII Vestibulococlearis Kaji kemampuan klien untuk mendengarkan kata yang diucapkan pemeriksa 9. IX Glossopharingeus a. Minta klien untuk mengidentifikasi rasa asam, asin, dan manis pada bagian posterior lidah b. Gunakan spatel lidah untuk memeriksa reflek gags c. Minta klien untuk menggerakkan lidahnya 10. X Vagus a. Minta klien untuk mengucapkan kata "ah" dan observasi pergerakan palate, dan faring b. Gunakan spatel lidah untuk memeriksa reflek gags c. Kaji adanya suara parau ketika klien berbicara 11. XI Accesorius Minta klien untuk mengangkat bahu dan memalingkan wajah ke sisi yang ditahan oleh tangan anda secara pasif 12. XII Hipoglossus Minta klien untuk menjulurkan lidah sejajar garis tengah tubuh, kemudian menggerakkannya ke kanan dan ke kiri Tahap Terminasi 1. Lakukan cuci tangan 2. Lakukan evaluasi terhadap klien tentang kegiatan yang telah dilakukan Dokumentasi 1. Catat hasil tindakan yang telah dilakukan 2. Catat respon klien 3. Sampaikan hasil pemeriksaan pada klien 4. Lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya
--	--

BAB 7

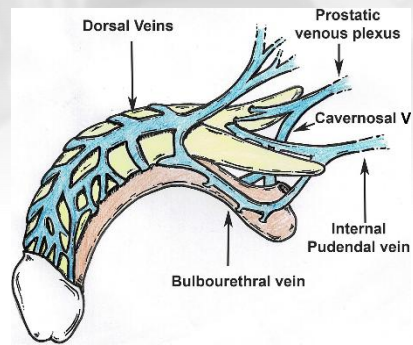
Pemeriksaan Genetalia dan Anus

A. Anatomi Genetalia dan Anus

1. Anatomi Genitalia Pada Pria

a. Penis

Penis merupakan organ reproduksi eksternal pria yang terdiri atas batang dan ujung yang disebut glans penis. Batang penis tersusun dari tiga jaringan erektile, yaitu dua korpus kavernosum di bagian dorsal dan satu korpus spongiosum di bagian ventral yang mengelilingi uretra. Fungsi penis adalah sebagai alat kopulasi untuk menyalurkan sperma ke dalam vagina serta sebagai jalur pengeluaran urine.



Gambar 7.1 Penis

b. Skrotum

Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di bawah penis dan berfungsi untuk melindungi testis. Skrotum memiliki otot yang disebut otot dartos yang dapat mengatur suhu testis dengan mengerut atau melonggarkan kulit skrotum. Fungsi utama skrotum adalah untuk menjaga suhu testis tetap pada tingkat yang ideal (sekitar 2–3 derajat Celcius lebih rendah dari suhu tubuh) agar produksi sperma optimal.

c. Testis

Testis merupakan kelenjar reproduksi pria yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis berada di dalam skrotum, dilapisi oleh tunika albuginea, dan tersusun atas banyak tubulus seminiferus yang menjadi tempat pembentukan

sperma.

d. Epididimis

Epididimis adalah saluran yang terletak di bagian belakang testis, di mana sperma disimpan dan matang sebelum dikeluarkan melalui saluran ejakulasi.

e. Vas deferens

Vas deferens adalah saluran panjang yang membawa sperma dari epididimis menuju uretra, tempat sperma dicampur dengan cairan dari kelenjar prostat dan vesikula seminalis untuk membentuk semen.

f. Kelenjar Prostat

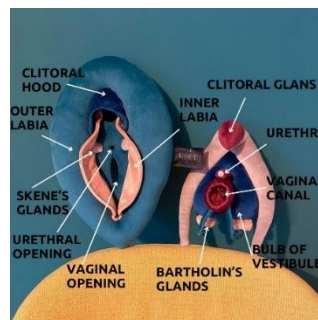
Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan prostat yang menjadi komponen semen, berfungsi mendukung kelangsungan hidup sperma dengan memberikan nutrisi, melindungi, dan membantu mobilitas sperma menuju sel telur.

2. Anatomi Genetalia Pada Wanita

a. Vulva

Vulva adalah bagian luar dari alat kelamin perempuan yang meliputi beberapa struktur, seperti:

- 1) Labia mayor: Lipatan kulit luar yang lebih besar dan lebih tebal, yang berfungsi melindungi bagian dalam genitalia.
- 2) Labia minor: Lipatan kulit yang lebih kecil dan lebih halus yang terletak di dalam labia mayor. Bagian ini mengelilingi pintu masuk vagina dan uretra.
- 3) Klitoris: Organ kecil yang sangat sensitif yang terletak di bagian depan vulva, di antara labia minor. Klitoris berfungsi sebagai pusat rangsangan seksual perempuan.
- 4) Pembukaan uretra: Saluran kecil di antara klitoris dan vagina, tempat keluarnya urine.
- 5) Pembukaan vagina: Saluran yang menghubungkan bagian luar genitalia dengan rahim, melalui mana darah menstruasi keluar dan sperma masuk.



Gambar 7.2 Anatomi Genitalia Eksterna Wanita (vulva)

b. Vagina

Vagina merupakan saluran elastis yang menghubungkan vulva dengan rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan lahir saat persalinan, tempat masuknya sperma pada hubungan seksual, serta jalur keluarnya darah menstruasi. Dinding vagina dilapisi mukosa yang bersifat elastis sehingga mampu menyesuaikan ukuran dan bentuk sesuai kebutuhan fisiologis.

c. Serviks (Leher Rahim)

Serviks adalah bagian inferior rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina dan berperan sebagai penghalang antara rongga uterus dan lingkungan luar. Saluran serviks menghasilkan lendir yang mengalami perubahan selama siklus menstruasi, berfungsi membantu proses fertilisasi serta melindungi rahim dari masuknya mikroorganisme.

d. Rahim (Uterus)

Rahim adalah organ berongga berbentuk pir yang terletak di dalam panggul perempuan. Rahim berfungsi untuk tempat perkembangan janin selama kehamilan. Rahim terdiri dari beberapa bagian, yaitu lapisan luar (perimetrium), lapisan otot (myometrium), dan lapisan dalam yang disebut endometrium, yang akan mengalami perubahan sepanjang siklus menstruasi.

e. Ovarium (Indung Telur)

Ovarium adalah kelenjar reproduksi perempuan yang berada di sisi kanan dan kiri rahim. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur (ovum) serta hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam pengaturan siklus menstruasi dan keberlangsungan kehamilan.

f. Tuba Fallopi

Tuba fallopi merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim dan menjadi lokasi terjadinya fertilisasi. Setelah pembuahan, ovum yang telah dibuahi akan bergerak menuju rahim untuk berimplantasi pada endometrium dan berkembang menjadi janin.

3. Anus

a. Anus

Anus adalah lubang keluar dari saluran pencernaan yang terletak di ujung bawah rektum, melalui mana tinja dikeluarkan dari tubuh. Anus terdiri dari otot-otot yang mengontrol pembukaan dan penutupan saluran tersebut, yang disebut sfingter anal.

b. Sfingter Anal

Sfingter anal adalah dua lapisan otot yang mengelilingi anus dan bertanggung jawab untuk mengatur pembukaan dan penutupan anus.

- 1) Sfingter anal eksternal: Otot ini terletak di sekitar anus dan dikendalikan secara sadar, memungkinkan kontrol pada saat buang air besar.
- 2) Sfingter anal internal: Otot ini terletak di dalam dan dikendalikan secara otomatis (tidak sadar), berfungsi untuk menahan tinja agar tidak keluar secara tidak sengaja.

c. Rektum

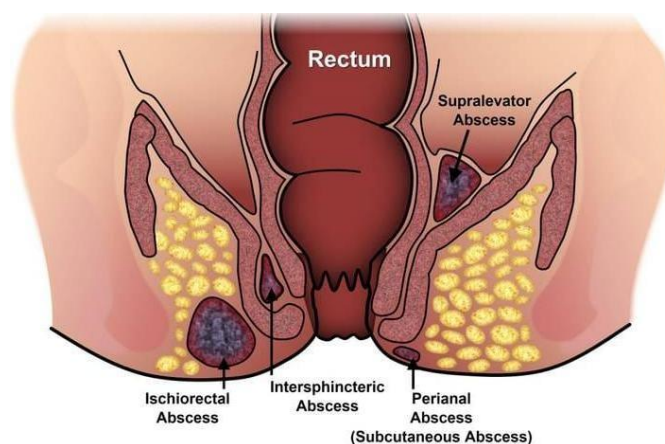
Rektum adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan yang terletak di antara kolon sigmoid dan anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penampungan sementara tinja sebelum dikeluarkan melalui anus. Pada bagian rektum, terdapat lapisan mukosa yang membantu pergerakan tinja menuju anus.

d. Saluran Anal

Saluran anal adalah bagian yang lebih sempit dari rektum yang terletak dekat dengan anus. Saluran ini dilapisi oleh kulit dan mukosa. Saluran anal mengandung kelenjar yang dapat mengeluarkan lendir untuk melumasi tinja saat melewati anus.

e. Kelenjar Anal

Kelenjar-kelenjar di sekitar anus menghasilkan cairan yang membantu pelumasan selama buang air besar. Kelenjar ini juga dapat menjadi sumber infeksi atau abses jika terinfeksi atau tersumbat.



Gambar 7.3 Jenis dan Lokasi Abses Anorektal

B. Prosedur Pemeriksaan Fisik Genetalia dan Anus

Berikut merupakan prosedur pemeriksaan fisik di area genetalia dan anus:

1. Sebelum tindakan dilakukan, pasien perlu diberikan penjelasan mengenai tujuan dan proses pemeriksaan. Pemeriksa harus menyadari bahwa prosedur ini berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman atau malu. Oleh karena itu, pemeriksaan dilakukan sesuai indikasi dengan tetap menjaga etika, kesopanan, serta menghormati privasi dan martabat pasien maupun pemeriksa.
2. Dekatkan alat-alat yang dibutuhkan sesuai dengan pemeriksaan. Jangan lupa universal precaution!
3. Keterlibatan perawat dalam melakukan pengkajian tingkat mahir (pengkajian alat kelamin bagian dalam) bergantung pada kebijaksanaan/peraturan di tempat perawat bekerja.
4. Pastikan lingkungan sekitar pasien aman dan pasien merasa nyaman.
5. Posisi pasien litotomi, pemeriksa berada di sebelah bawah pasien (pada pasien wanita). Posisi pasien dapat terlentang dan berdiri (pada pasien pria). Pastikan untuk menutupi (dengan selimut) bagian yang tidak di amati.
6. Untuk pemeriksaan anus, posisi pasien (pria/wanita) adalah posisi sims.
7. Berikan kesempatan kepada pasien untuk mengosongkan kandung kemih sebelum pengkajian dilakukan. Apabila diperlukan pemeriksaan urine sebagai spesimen laboratorium, pemeriksa menyiapkan wadah penampung yang sesuai.
8. Catat hasil pemeriksaan dengan jelas dan tepat.

Prosedur pemeriksaan genetalia pria:

1. Inspeksi rambut pubis: perhatikan penyebaran, pola pertumbuhan, dan kebersihannya.
2. Inspeksi kulit dan ukuran penis: adakah lesi, pembengkakan atau benjolan, dan adanya kelainan lain yang tampak pada batang penis.
3. Inspeksi kepala penis untuk melihat meatus uretra: apakah ada cairan yang keluar, adakah lesi/oedema/inflamasi atau tidak, lubang uretra normalnya terletak di tengah kepala penis.
4. Pada pasien yang belum menjalani sirkumsisi, prepusium ditarik untuk mengevaluasi glans penis dan meatus uretra; secara normal prepusium dapat ditarik dengan mudah. Apabila pasien merasa tidak nyaman, tindakan ini dapat dilakukan sendiri oleh pasien. Pada glans penis umumnya ditemukan sedikit smegma berwarna putih kekuningan. Pada pasien yang telah disirkumsisi, glans penis tampak kemerahan, kering, dan tidak ditemukan smegma.

5. Inspeksi skrotum dan perhatikan: ukuran, bentuk, kesimetrisan, warna (normal hiperpigmentasi), adanya lesi/edema atau tidak.
6. Palpasi permukaan kulit skrotum: adakah benjolan atau tidak. Normalnya teraba longgar dan kasar. Skrotum kontraksi pada suhu dingin dan relaks pada suhu hangat.
7. Palpasi skrotum dan testis dengan menggunakan jempol dan tiga jari pertama. Palpasi tiap testis dan perhatikan ukuran, konsistensi, bentuk, dan tekstur
8. kelucinaannya. Testis normalnya teraba lunak, elastis, licin, tidak ada benjolan atau massa, berukuran sekitar 2-4 cm, dan testis kiri lebih rendah dibanding testis kanan.
9. Lakukan palpasi penis untuk mengetahui: adanya nyeri tekan atau tidak, adanya benjolan pada batang penis, dan kemungkinan adanya cairan kental yang keluar
10. Inspeksi anus: adakah hemoroid/kutil/herpes/benjolan atau tidak, perhatikan kebersihan.
11. Palpasi anus dan rektum dilakukan menggunakan jari dengan sarung tangan dan pelumas. Selama pemeriksaan, perhatikan adanya nyeri tekan, keluarnya cairan atau darah, kondisi dinding rektum seperti benjolan atau polip, serta ukuran dan konsistensi kelenjar prostat untuk menilai kemungkinan hiperplasia.

Prosedur pemeriksaan genetalia wanita:

1. Inspeksi rambut pubis: penyebaran, pola pertumbuhan, dan kebersihannya.
2. Inspeksi dilakukan pada labia mayora dan struktur internal, meliputi klitoris, labia minora, orifisium uretra, dan orifisium vagina. Labia mayora dibuka secara lateral menggunakan jari satu tangan. Selama pemeriksaan, dinilai kesimetrisan labia, warna mukosa yang normal merah muda, adanya tanda iritasi atau inflamasi, karakter sekret (warna dan bau), serta keberadaan polip atau benjolan.
3. Inspeksi perineum: normal kulit perineal lebih gelap, halus, dan bersih.
4. Inspeksi anus: adakah hemoroid/kutil/herpes/benjolan atau tidak, perhatikan kebersihan.
5. Palpasi anus dan rektum dengan jari (menggunakan sarung tangan dan beri pelumas), perhatikan: adakah nyeri tekan atau tidak, adakah cairan/darah yang keluar, raba dinding rektum (adakah benjolan/polip atau tidak), raba kelenjar prostat (apakah mengalami hiperplasia atau tidak).

Cara pengkajian tingkat mahir:

1. Lumasi jari telunjuk pemeriksa dengan air steril, masukkan ke dalam vagina, dan identifikasi kelunakan serta permukaan serviks. Tindakan ini bermanfaat untuk mempergunakan dan memilih spekulum yang tepat. Keluarkan jari bila sudah selesai
2. Siapkan spekulum dengan ukuran dan bentuk yang sesuai dan lumasi dengan air hangat terutama bila akan mengambil spesimen
3. Letakkan dua jari pada pintu vagina dan tekankan ke bawah ke arah perineal
4. Yakinkan bahwa tidak ada rambut pubis pada pintu vagina dan masukkan spekulum dengan sudut 45° dan hati-hati dengan menggunakan tangan yang satunya sehingga tidak menjepit rambut pubis atau labia
5. Bila spekulum sudah berada di vagina, keluarkan dua jari pemeriksa, dan putar spekulum ke arah posisi horizontal dan pertahankan penekanan pada sisi bawah/posterior
6. Buka bilah spekulum, letakkan pada serviks, dan kunci bilah sehingga tetap membuka
7. Setelah serviks tampak jelas, pencahayaan diatur untuk memperoleh visualisasi optimal. Pemeriksaan meliputi penilaian ukuran, adanya laserasi, nodularitas, erosi, massa, serta warna serviks. Serviks normal tampak merah muda mengilap dengan permukaan halus, berdiameter sekitar 3 cm, berbentuk bulat atau oval pada nulipara, dan berbentuk celah pada multipara.
8. Bila diperlukan spesimen sitologi, ambil dengan cara usapan menggunakan aplikator dari kapas.
9. Bila sudah selesai, kendurkan sekrup spekulum, tutup spekulum, dan tarik keluar secara perlahan-lahan.
10. Apabila diperlukan, palpasi bimanual dilakukan dengan menggunakan sarung tangan steril. Jari telunjuk dan jari tengah diberi pelumas, kemudian dimasukkan ke dalam vagina dengan teknik yang lembut untuk melakukan penilaian lebih lanjut.
11. posterior, dan meraba dinding vagina untuk mengetahui adanya nyeri tekan dan nodular.
12. Palpasi serviks dengan dua jari pemeriksa dan perhatikan posisi, ukuran, konsistensi, regularitas, mobilitas, dan nyeri tekan. Normalnya serviks dapat digerakkan tanpa terasa nyeri.
13. Palpasi uterus dilakukan dengan posisi jari di dalam vagina menghadap ke atas, sementara tangan lain menekan abdomen ke arah bawah pada kuadran kanan bawah. Ovarium kanan dipalpasi untuk menilai ukuran, bentuk, mobilitas, konsistensi, serta adanya nyeri tekan; secara normal ovarium tidak teraba. Prosedur yang sama diulangi pada ovarium sisi kiri.

C. Latihan Soal

1. Pemeriksaan genetalia bertujuan menilai ...
 - A. Sistem respirasi
 - B. Sistem reproduksi
 - C. Sistem kardiovaskular
 - D. Sistem integument
2. Pemeriksaan harus dilakukan dengan prinsip ...
 - A. Cepat
 - B. Minimal alat
 - C. Privasi dan etika
 - D. Bebas
3. Posisi pasien umum pada pemeriksaan anus adalah ...
 - A. Supinasi
 - B. Sims
 - C. Fowler
 - D. Trendelenburg
4. Pemeriksaan anus bertujuan menilai ...
 - A. Hemoroid
 - B. Fisura
 - C. Massa
 - D. Semua benar
5. Inspeksi genetalia menilai ...
 - A. Refleks
 - B. Warna dan lesi
 - C. Tekanan darah
 - D. Kesadaran
6. Palpasi dilakukan untuk menilai ...
 - A. Bau
 - B. Nyeri dan massa
 - C. Warna
 - D. Sekresi
7. Pemeriksaan harus disertai ...
 - A. Informed consent
 - B. Obat analgesik
 - C. Anestesi lokal
 - D. Puasa
8. Pemeriksaan genetalia bersifat ...
 - A. Darurat
 - B. Sensitif
 - C. Tidak penting
 - D. Opsional
9. Pemeriksaan anus sebaiknya dilakukan ...
 - A. Tanpa sarung tangan
 - B. Dengan sarung tangan
 - C. Tanpa penjelasan
 - D. Tanpa izin
10. Tujuan utama pemeriksaan adalah ...
 - A. Diagnosis dini
 - B. Estetika
 - C. Kenyamanan pemeriksa
 - D. Dokumentasi saja

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN FISIK GENETALIA DAN ANUS	
Pengertian	Melakukan pemeriksaan/pengkajian fisik secara lengkap
Tujuan	1. Menegakkan diagnosa 2. Mengenali kelainan pada klien 3. Sebagai data dasar
Persiapan Alat/Bahan	1. Handscoon non steril 2. Penlight 3. Metlin 4. Stetoskop 5. Kasa 6. Bengkok 7. Buku catatan 8. Pena
Prosedur Tindakan	Tahap Persiapan: 1. Justifikasi identitas klien (nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis) 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan 3. Lakukan cuci tangan Komunikasi Terapeutik: 1. Perkenalkan diri 2. Jelaskan pada klien tujuan tindakan yang akan dilakukan 3. Jaga privasi klien dan atur lingkungan sekitar klien 4. Bantu klien untuk mengatur posisi senyaman mungkin Tahap Kerja Pemeriksaan Genetalia Laki-laki 1. Klien dalam posisi tidur telentang 2. Amati rambut pubis (pertumbuhan dan penyebaran) 3. Perhatikan ukuran, kulit dan adanya kelainan pada penis 4. Pada pasien pria yang belum disunat, penis dipegang dan preputium ditarik untuk membuka muara penis, kemudian dilakukan pengamatan pada lubang uretra dan glans penis untuk menilai adanya ulkus, nodul, atau tanda-tanda peradangan. Palpasi penis terhadap nyeri tekan dan keluaran 5. Palpasi testis dan skrotum dengan menggunakan ibu jari dan tiga jari pertama lakukan terhadap ukuran, konsistensi, bentuk dan kelicinan 6. Inspeksi area inguinal dan femoral (pembengkakan) 7. Lakukan palpasi untuk mengetahui adanya hernia dengan cara: a. Minta klien berdiri dengan sebelah kaki (sisi yang diperiksa agak ditekuk) b. Masukkan jari telunjuk ke dalam kulit skrotum dan dorong ke atas cincin

	inguinal eksterna c. Bila cincin membesar, masukkan jari melalui cincin dan suruh klien mengejan/batuk (jika teraba berarti hernia inguinal) 8. Lakukan palpasi paha anterior dan minta klien batuk untuk mengetahui hernia femoral 9. Ubah posisi klien ke posisi sim dengan tungkai fleksi maksimal 10. Inspeksi area anus terhadap perdarahan, hemorroid, benjolan/pembengkakan pada perinium 11. Palpasi terhadap adanya nyeri tekan 12. Palpasi reflek anal eksterna dengan menggores kulit sekitar anus dengan benda agak runcing (kulit mengerut saat digores, maka reflek positif) Perempuan 1. Posisi klien litotomi dan selimuti bagian yang tidak diperiksa 2. Amati rambut pubis (distribusi dan pertumbuhannya) 3. Perhatikan kulit dan area pubis terhadap adanya lesi, eritema dll 4. Buka labia mayor dengan menggunakan sarung tangan 5. Amati bagian dalam labia mayora, labia minora, klitoris dan meatus uretra untuk menilai adanya pembengkakan, ulkus, keluaran, pembengkakan, dll. Ubah posisi klien dengan posisi sim dengan tungkai fleksi maksimal 6. Inspeksi area anus terhadap perdarahan, haemorroid, benjolan/pembengkakan pada perineum 7. Palpasi terhadap adanya nyeri tekan 8. Palpasi reflek anal eksterna dengan menggores kulit sekitar anus dengan benda agak runcing (kulit mengerut saat digores, maka reflek positif) Pemeriksaan Ekstremitas 1. Mengkaji postur klien 2. Mengkaji cara berjalan pergerakan klien 3. Menginspeksi ukuran otot, bentuk dan kontur sendi 4. Mempalpasi otot, sendi, rentang gerak dan kekuatan otot Tahap Terminasi 1. Lakukan cuci tangan 2. Lakukan evaluasi terhadap klien tentang kegiatan yang telah dilakukan Dokumentasi 1. Catat hasil tindakan yang telah dilakukan 2. Catat respon klien 3. Sampaikan hasil pemeriksaan pada klien 4. Lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya
--	--

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2014). *Kebutuhan dasar manusia*. Trans Info Media.
- Alomedik. (n.d.). Alomedik. <https://www.alomedik.com>
- Aminoff. (n.d.). *Harrison's principles of internal medicine: Neurologi klinis*.
- Bahrudin, M. (2011). *Pemeriksaan klinis di bidang penyakit syaraf*. UMM Press.
- Bates, B. (1997). *Buku saku pemeriksaan fisik & riwayat kesehatan* (Edisi 2). EGC.
- Debora, O. (2011). *Proses keperawatan dan pemeriksaan fisik*. Salemba Medika.
- Engka, A. A. A., dkk. (2022). Postur kerja dan keluhan muskuloskeletal pada nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(4), 44.
- Farida, A., dkk. (2016). *Pemeriksaan fisik head to toe*. Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo.
- Halodoc. (n.d.). Halodoc. <https://www.halodoc.ncbi.nih.gov>
- Handayani, S. (2021). *Anatomi dan fisiologi tubuh manusia* (hlm. 15–17). CV Media Sains Indonesia.
- Hopkins Medicine. (n.d.). Johns Hopkins Medicine. <https://www.hopkinsmedicine.org>
- Kusyati, E., dkk. (2006). *Keterampilan & prosedur laboratorium keperawatan dasar*. Buku Kedokteran.
- Kusyati, E., dkk. (2014). *Keterampilan & prosedur laboratorium keperawatan dasar* (Edisi 2). EGC.
- Mitra Keluarga. (n.d.). *Mengenal pemeriksaan fisik yang penting untuk kesehatan*. <https://www.mitrakeluarga.com/artikel/pemeriksaan-fisik>
- Muttaqin, A., & Sari, K. (2011). *Asuhan keperawatan gangguan sistem integumen*. Salemba Medika.
- Neurologi Udayana. (n.d.). Neurologi Udayana. <https://neurologiudayana.com>
- Nurmalasari, R., & Aprianoro, R. N. (2020). Pemeriksaan radiografi thorax dengan kasus tuberkulosis paru. *Webinar Nasional Cendekiawan*, (1).
- Pintaningrum, Y. (2022). *Pemeriksaan fisik thoraks*. Madza Media.
- Potter, P. A. (2005). *Buku ajar fundamental keperawatan*. EGC.
- Potter, P. A. (2010). *Fundamental keperawatan* (Edisi 7, Buku 2). Salemba Medika.
- Priharjo, R. (2006). *Pengkajian fisik keperawatan*. EGC.

- Ruhyanudin, F. (2013). *Pemeriksaan neurologis*. Academia.edu.
http://www.academia.edu/11048910/Pemeriksaan_Neurologis
- S. F. R. (2012, June 4). *Pemeriksaan fisik sistem neuro*. Alvivo23.
<https://alvivo23.wordpress.com/2012/06/04/pemeriksaan-fisiksistem-neuro/>
- Suratun, L., & Heri, S. Y. (2010). *Asuhan keperawatan klien gangguan sistem gastrointestinal*. Trans Info Media.
- Suselo, Y. H. (2019). *Buku manual keterampilan klinik*. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret, Fakultas Kedokteran.
- Syaifuiddin. (2010). *Anatomi dan fisiologi: Kurikulum berbasis kompetensi untuk keperawatan dan kebidanan* (Edisi 4). EGC.
- Yarsa, K. Y., dkk. (2019). *Pedoman keterampilan klinis pemeriksaan payudara*.

Kunci Jawaban

BAB I

1. Sistem integumen terutama berfungsi sebagai ...

Jawaban: C. Pelindung tubuh dari lingkungan luar

Pembahasan: Sistem integumen (kulit, rambut, kuku) berfungsi utama sebagai barier protektif terhadap trauma fisik, mikroorganisme, zat kimia, serta membantu mencegah kehilangan cairan dan menjaga suhu tubuh.

2. Lapisan kulit yang berasal dari ektoderm adalah ...

Jawaban: C. Epidermis

Pembahasan: Epidermis berasal dari ektoderm, sedangkan dermis berasal dari mesoderm. Hal ini penting dalam memahami regenerasi kulit dan proses penyembuhan luka.

3. Fungsi utama dermis adalah ...

Jawaban: C. Memberikan kekuatan dan elastisitas kulit

Pembahasan: Dermis mengandung kolagen dan elastin yang berperan menjaga kekuatan struktural dan elastisitas kulit, serta pembuluh darah, saraf, dan kelenjar.

4. Lapisan kulit yang mengandung jaringan lemak disebut ...

Jawaban: D. Hipodermis

Pembahasan: Hipodermis (jaringan subkutan) kaya akan jaringan lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi, isolator panas, dan bantalan mekanik.

5. Rambut tidak ditemukan pada area berikut, kecuali ...

Jawaban: D. Kulit kepala

Pembahasan: Rambut tidak ditemukan pada telapak tangan, telapak kaki, dan dorsal falang distal. Kulit kepala merupakan area dengan folikel rambut paling banyak.

6. Bagian rambut yang tertanam dalam kulit disebut ...

Jawaban: C. Akar rambut

Pembahasan: Akar rambut berada di dalam kulit dan berfungsi sebagai tempat pertumbuhan rambut. Batang rambut berada di atas permukaan kulit.

7. Lunula pada kuku merupakan ...

Jawaban: C. Area pembentukan kuku baru

Pembahasan: Lunula adalah bagian matriks kuku yang tampak berwarna putih pucat, berperan dalam pembentukan sel kuku baru.

8. Sudut normal antara kuku dan pangkal kuku adalah ...

Jawaban: D. 160°

Pembahasan: Sudut normal (*Lovibond angle*) sekitar 160°. Sudut yang lebih besar dapat mengindikasikan clubbing finger, sering terkait hipoksia kronis.

9. Nilai normal Capillary Refill Time (CRT) adalah ...

Jawaban: B. < 2 detik

Pembahasan: CRT normal kurang dari 2 detik menunjukkan perfusi perifer yang adekuat. CRT memanjang dapat mengindikasikan gangguan sirkulasi atau dehidrasi.

10. Sianosis menunjukkan adanya ...

Jawaban: B. Hipoksia

Pembahasan: Sianosis terjadi akibat peningkatan hemoglobin tereduksi dalam darah dan merupakan tanda kekurangan oksigen (hipoksia) pada jaringan.

BAB II

1. Pemeriksaan kepala dilakukan terutama dengan teknik ...

Jawaban: B. Inspeksi dan palpasi

Pembahasan: Pemeriksaan kepala menitikberatkan pada bentuk, simetri, dan adanya benjolan atau nyeri tekan, sehingga teknik utama yang digunakan adalah inspeksi dan palpasi. Auskultasi dan perkusi tidak rutin digunakan pada pemeriksaan kepala.

2. Kepala normal secara posisi adalah ...

Jawaban: C. Tegak lurus pada garis tengah tubuh

Pembahasan: Posisi kepala normal berada simetris dan tegak lurus terhadap garis tengah tubuh. Deviasi dapat mengindikasikan kelainan muskuloskeletal atau neurologis.

3. Ubun-ubun pada dewasa normalnya ...

Jawaban: D. Menutup

Pembahasan: Ubun-ubun (fontanel) menutup sempurna pada usia dewasa. Ubun-ubun terbuka hanya ditemukan pada bayi dan anak kecil.

4. Pemeriksaan konjungtiva dilakukan untuk menilai ...

Jawaban: B. Anemia

Pembahasan: Konjungtiva yang pucat merupakan tanda anemia, sedangkan ikterus dinilai pada sklera.

5. Nilai normal tekanan intraokular adalah ...

Jawaban: C. 11–21 mmHg

Pembahasan: Tekanan intraokular normal berkisar 11–21 mmHg. Nilai di atas batas ini mengarah pada risiko glaukoma.

6. Tes Rinne positif menunjukkan ...

Jawaban: B. Tuli sensorineural

Pembahasan: Rinne positif berarti hantaran udara lebih lama daripada hantaran tulang ($AC > BC$), kondisi ini normal atau menunjukkan tuli sensorineural.

7. Pada tes Weber, lateralisasi ke telinga sakit menunjukkan ...

Jawaban: B. Tuli konduktif

Pembahasan:

Pada tuli konduktif, suara melateral ke telinga yang mengalami gangguan, sedangkan pada tuli sensorineural melateral ke telinga yang sehat.

8. Pemeriksaan hidung bertujuan menilai, kecuali ...

Jawaban: C. Refleks pupil

Pembahasan:

Refleks pupil termasuk pemeriksaan mata dan saraf kranial, bukan bagian dari pemeriksaan hidung.

9. Ucapan “aaa” saat pemeriksaan faring bertujuan menilai ...

Jawaban: C. Saraf kranial IX dan X

Pembahasan:

Ucapan “aaa” menilai elevasi uvula dan refleks menelan yang dikendalikan oleh nervus glossopharyngeus (IX) dan vagus (X).

10. Deviasi trakea umumnya disebabkan oleh ...

Jawaban: A. Kelainan rongga dada

Pembahasan:

Deviasi trakea sering disebabkan oleh kondisi intratorakal seperti pneumotoraks, efusi pleura, atau massa mediastinum.

BAB III

1. Frekuensi napas normal dewasa adalah ...

Jawaban: C. 12–20 x/menit

Pembahasan:

Rentang ini merupakan nilai normal respirasi dewasa sehat. Nilai di luar rentang mengindikasikan gangguan respirasi.

2. Takipnea didefinisikan sebagai RR ...

Jawaban: C. > 20 x/menit

Pembahasan:

Takipnea menunjukkan peningkatan frekuensi napas dan sering ditemukan pada kondisi hipoksia, demam, atau gangguan paru.

3. Bentuk dada barrel chest umumnya ditemukan pada ...

Jawaban: A. Anak-anak

Pembahasan:

Pada anak-anak, diameter anteroposterior dan transversal relatif sama. Pada dewasa, barrel chest sering dikaitkan dengan PPOK, namun secara konsep dasar anatomi sering diperkenalkan pada anak.

4. Lokasi normal apeks jantung adalah ...

Jawaban: C. ICS 5 kiri garis midklavikula

Pembahasan:

Lokasi ini menjadi acuan penting dalam inspeksi dan palpasi impuls apikal jantung.

5. Fremitus vokal meningkat pada kondisi ...

Jawaban: C. Konsolidasi paru

Pembahasan:

Pada konsolidasi (misalnya pneumonia), penghantaran getaran suara meningkat karena jaringan paru menjadi lebih padat.

6. Suara perkusi hipersonor menandakan ...

Jawaban: C. Udara berlebih

Pembahasan:

Hipersonor menunjukkan peningkatan udara, misalnya pada emfisema atau pneumotoraks.

7. Bunyi jantung S1 berasal dari ...

Jawaban: B. Penutupan katup AV

Pembahasan:

S1 terjadi akibat penutupan katup mitral dan trikuspid pada awal sistol.

8. Bising diastolik hampir selalu menunjukkan ...

Jawaban: B. Gangguan katup

Pembahasan:

Berbeda dengan bising sistolik yang bisa fisiologis, bising diastolik selalu dianggap patologis.

9. Grade 4 bising jantung ditandai oleh ...

Jawaban: C. Disertai thrill

Pembahasan:

Grade 4 sudah cukup kuat hingga menimbulkan getaran yang dapat diraba (thrill).

10. Patent Ductus Arteriosus ditandai oleh bising ...

Jawaban: D. Menerus

Pembahasan:

PDA menghasilkan continuous murmur ("machinery murmur") karena aliran darah abnormal sepanjang siklus jantung.

BAB IV

1. Urutan pemeriksaan abdomen yang benar adalah ...

Jawaban: B. Inspeksi–auskultasi–perkusi–palpasi

Pembahasan:

Auskultasi dilakukan sebelum perkusi dan palpasi untuk mencegah perubahan bising usus akibat manipulasi.

2. Auskultasi abdomen bertujuan menilai ...

Jawaban: B. Bising usus

Pembahasan:

Bising usus mencerminkan aktivitas peristaltik saluran cerna.

3. Palpasi abdomen dalam dilakukan untuk menilai ...

Jawaban: C. Massa dan organ dalam

Pembahasan:

Palpasi dalam digunakan untuk mendeteksi pembesaran organ, massa, atau nyeri dalam.

4. Perkusi abdomen berguna untuk menilai ...

Jawaban: A. Densitas jaringan

Pembahasan:

Perkusi membantu membedakan jaringan padat, cair, dan udara melalui variasi bunyi.

5. Suara timpani menunjukkan adanya ...

Jawaban: C. Udara

Pembahasan:

Timpani merupakan bunyi normal pada lambung dan usus yang berisi gas.

6. Nyeri lepas tekan disebut ...

Jawaban: C. Rebound tenderness

Pembahasan:

Nyeri yang muncul saat tekanan dilepas menandakan iritasi peritoneum, sering pada apendisitis.

7. Hati normal teraba ...

Jawaban: D. Sedikit di bawah arkus kosta kanan

Pembahasan:

Pada orang dewasa sehat, hati dapat teraba tipis saat inspirasi dalam.

8. Bising usus normal terdengar ...

Jawaban: B. 5–30 kali/menit

Pembahasan:

Nilai ini mencerminkan peristaltik normal. Tidak adanya bising usus perlu dicurigai ileus.

9. Distensi abdomen dapat disebabkan oleh ...

Jawaban: D. Semua benar

Pembahasan:

Distensi dapat disebabkan oleh gas, cairan, maupun massa, sehingga memerlukan pengkajian lanjut.

10. Palpasi harus dilakukan terakhir karena ...

Jawaban: B. Mengganggu bising usus

Pembahasan:

Palpasi dapat merangsang atau menekan peristaltik, sehingga mengubah hasil auskultasi.

BAB V

1. Sistem muskuloskeletal berfungsi utama untuk ...

Jawaban: C. Pergerakan dan postur

Pembahasan:

Sistem muskuloskeletal berperan utama dalam pergerakan tubuh, mempertahankan postur, dan menopang tubuh, selain fungsi proteksi organ dan penyimpanan mineral.

2. Pemeriksaan muskuloskeletal menilai ...

Jawaban: B. Range of Motion

Pembahasan:

Pemeriksaan fokus pada ROM, kekuatan otot, bentuk sendi, dan fungsi, bukan sistem lain seperti refleks pupil atau tekanan darah.

3. Pemeriksaan ROM aktif berarti ...

Jawaban: D. Dilakukan pasien sendiri

Pembahasan:

ROM aktif dilakukan oleh pasien tanpa bantuan pemeriksa dan mencerminkan fungsi sendi, otot, serta koordinasi saraf.

4. Nyeri saat pergerakan menunjukkan kemungkinan ...

Jawaban: A. Inflamasi

Pembahasan:

Nyeri yang muncul saat gerak sering berkaitan dengan peradangan sendi, otot, atau jaringan sekitar.

5. Krepitasi biasanya ditemukan pada ...

Jawaban: D. Semua benar

Pembahasan:

Krepitasi (sensasi gemeretak) dapat ditemukan pada fraktur, artritis, maupun dislokasi akibat gesekan abnormal struktur sendi.

6. Deformitas sendi menandakan ...

Jawaban: A. Kelainan struktural

Pembahasan:

Deformitas menunjukkan perubahan bentuk sendi akibat kelainan kronis, trauma, atau penyakit degeneratif.

7. Kekuatan otot dinilai dengan skala ...

Jawaban: C. 0–5

Pembahasan:

Skala kekuatan otot 0–5 digunakan secara internasional, dari tidak ada kontraksi (0) hingga kekuatan normal (5).

8. Postur normal ditandai oleh ...

Jawaban: C. Keseimbangan simetris

Pembahasan:

Postur normal menunjukkan keselarasan dan keseimbangan simetris tanpa deviasi tulang belakang yang patologis.

9. Pemeriksaan muskuloskeletal dilakukan secara ...

Jawaban: B. Sistematis

Pembahasan:

Pendekatan sistematis mencegah area terlewat dan memastikan pengkajian menyeluruh dan objektif.

10. Tujuan utama pemeriksaan adalah ...

Jawaban: C. Menilai fungsi dan mobilitas

Pembahasan:

Dalam keperawatan, fokus utama adalah fungsi dan kemampuan mobilitas pasien, bukan penetapan diagnosis medis.

BAB VI

1. Pemeriksaan neurologis bertujuan menilai ...

Jawaban: B. Sistem saraf

Pembahasan:

Pemeriksaan neurologis mengevaluasi fungsi sistem saraf pusat dan perifer, termasuk kesadaran, refleks, dan saraf kranial.

2. Saraf kranial berjumlah ...

Jawaban: C. 12 pasang

Pembahasan:

Saraf kranial I–XII memiliki fungsi sensorik, motorik, atau campuran.

3. Refleks fisiologis normal menunjukkan ...

Jawaban: B. Fungsi neurologis baik

Pembahasan:

Refleks normal menunjukkan integritas jalur saraf sensorik dan motorik.

4. Tingkat kesadaran dinilai menggunakan ...

Jawaban: B. Glasgow Coma Scale

Pembahasan:

GCS menilai respon mata, verbal, dan motorik untuk menentukan tingkat kesadaran.

5. Nervus optikus berfungsi untuk ...

Jawaban: C. Penglihatan

Pembahasan:

Nervus optikus (CN II) adalah saraf sensorik utama untuk fungsi visual.

6. Nervus vagus berperan dalam ...

Jawaban: B. Fungsi otonom

Pembahasan:

Nervus vagus (CN X) berperan besar dalam regulasi organ visceral seperti jantung dan saluran cerna.

7. Penurunan refleks menunjukkan ...

Jawaban: C. Hiporefleksia

Pembahasan:

Hiporefleksia sering terkait dengan gangguan saraf perifer atau kerusakan jalur refleks.

8. Refleks patologis menandakan ...

Jawaban: B. Gangguan SSP

Pembahasan:

Refleks patologis (misalnya Babinski pada dewasa) menandakan kerusakan sistem saraf pusat.

9. Pemeriksaan neurologis harus dilakukan ...

Jawaban: C. Sistematis

Pembahasan:

Pendekatan sistematis penting karena pemeriksaan neurologis bersifat kompleks dan saling berkaitan.

10. Tujuan utama pemeriksaan neurologis adalah ...

Jawaban: C. Identifikasi gangguan

Pembahasan:

Pemeriksaan bertujuan mendeteksi lokasi dan jenis gangguan neurologis secara dini.

BAB VII

1. Pemeriksaan genetalia bertujuan menilai ...

Jawaban: B. Sistem reproduksi

Pembahasan:

Pemeriksaan ini menilai kondisi organ reproduksi dan saluran terkait, termasuk adanya kelainan atau infeksi.

2. Pemeriksaan harus dilakukan dengan prinsip ...

Jawaban: C. Privasi dan etika

Pembahasan:

Karena bersifat sensitif, pemeriksaan harus menjunjung etika, privasi, dan martabat pasien.

3. Posisi pasien umum pada pemeriksaan anus adalah ...

Jawaban: B. Sims

Pembahasan:

Posisi Sims memudahkan visualisasi area anus dan memberikan kenyamanan relatif bagi pasien.

4. Pemeriksaan anus bertujuan menilai ...

Jawaban: D. Semua benar

Pembahasan:

Pemeriksaan anus menilai hemoroid, fisura, massa, dan kelainan lain.

5. Inspeksi genetalia menilai ...

Jawaban: B. Warna dan lesi

Pembahasan:

Inspeksi bertujuan menilai warna, kebersihan, pembengkakan, dan lesi.

6. Palpasi dilakukan untuk menilai ...

Jawaban: B. Nyeri dan massa

Pembahasan:

Palpasi membantu mendeteksi nyeri tekan, pembesaran, atau massa abnormal.

7. Pemeriksaan harus disertai ...

Jawaban: A. Informed consent

Pembahasan:

Informed consent merupakan kewajiban etis dan legal sebelum pemeriksaan sensitif.

8. Pemeriksaan genetalia bersifat ...

Jawaban: B. Sensitif

Pembahasan:

Karena berkaitan dengan area privat, pemeriksaan ini memerlukan pendekatan komunikatif dan empatik.

9. Pemeriksaan anus sebaiknya dilakukan ...

Jawaban: B. Dengan sarung tangan

Pembahasan:

Penggunaan sarung tangan penting untuk pencegahan infeksi dan keselamatan pasien serta pemeriksa.

10. Tujuan utama pemeriksaan adalah ...

Jawaban: A. Diagnosis dini

Pembahasan:

Pemeriksaan bertujuan mendeteksi kelainan sejak dini agar dapat dilakukan intervensi yang tepat.

Sinopsis

Buku Pemeriksaan Fisik dalam Keperawatan disusun sebagai buku ajar yang bertujuan membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan memahami konsep dasar serta keterampilan pemeriksaan fisik secara sistematis dan komprehensif. Pemeriksaan fisik merupakan bagian penting dari proses pengkajian keperawatan karena menjadi dasar dalam mengidentifikasi kondisi kesehatan klien, menemukan masalah kesehatan secara dini, serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat. Oleh karena itu, buku ini menekankan pentingnya ketelitian, pendekatan holistik, dan penerapan prinsip profesional dalam praktik keperawatan.

Materi dalam buku ini disusun secara runtut berdasarkan sistem tubuh, dimulai dari pemeriksaan integumen dan kuku, kepala dan leher, thoraks, abdomen, sistem muskuloskeletal, sistem neurologis, hingga pemeriksaan genitalia dan anus. Setiap bab memuat penjelasan anatomi dan fisiologi, teknik pemeriksaan fisik seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, serta langkah-langkah pemeriksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan klinis. Selain itu, pembahasan juga memperhatikan aspek etika, privasi, dan komunikasi terapeutik dalam melakukan pemeriksaan kepada klien.

Untuk menunjang proses pembelajaran, buku ini dilengkapi dengan latihan soal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap bab, sehingga pembaca tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik. Dengan penyajian yang ringkas, sistematis, dan aplikatif, buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan maupun tenaga kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemeriksaan fisik secara profesional dan bertanggung jawab.

Buku Pemeriksaan Fisik dalam Keperawatan disusun sebagai buku ajar yang bertujuan membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan memahami konsep dasar serta keterampilan pemeriksaan fisik secara sistematis dan komprehensif. Pemeriksaan fisik merupakan bagian penting dari proses pengkajian keperawatan karena menjadi dasar dalam mengidentifikasi kondisi kesehatan klien, menemukan masalah kesehatan secara dini, serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat. Oleh karena itu, buku ini menekankan pentingnya ketelitian, pendekatan holistik, dan penerapan prinsip profesional dalam praktik keperawatan.

Materi dalam buku ini disusun secara runtut berdasarkan sistem tubuh, dimulai dari pemeriksaan integumen dan kuku, kepala dan leher, thoraks, abdomen, sistem muskuloskeletal, sistem neurologis, hingga pemeriksaan genetalia dan anus. Setiap bab memuat penjelasan anatomi dan fisiologi, teknik pemeriksaan fisik seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, serta langkah-langkah pemeriksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan klinis. Selain itu, pembahasan juga memperhatikan aspek etika, privasi, dan komunikasi terapeutik dalam melakukan pemeriksaan kepada klien.

Untuk menunjang proses pembelajaran, buku ini dilengkapi dengan latihan soal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap bab, sehingga pembaca tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik. Dengan penyajian yang ringkas, sistematis, dan aplikatif, buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan maupun tenaga kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemeriksaan fisik secara profesional dan bertanggung jawab.

ISBN 978-634-7556-52-3



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

